



Дайджест презентации к занятию по теме № 6

*Н.В. Материал НЕ замещает
учебную литературу, но помогает
структурировать тему!*

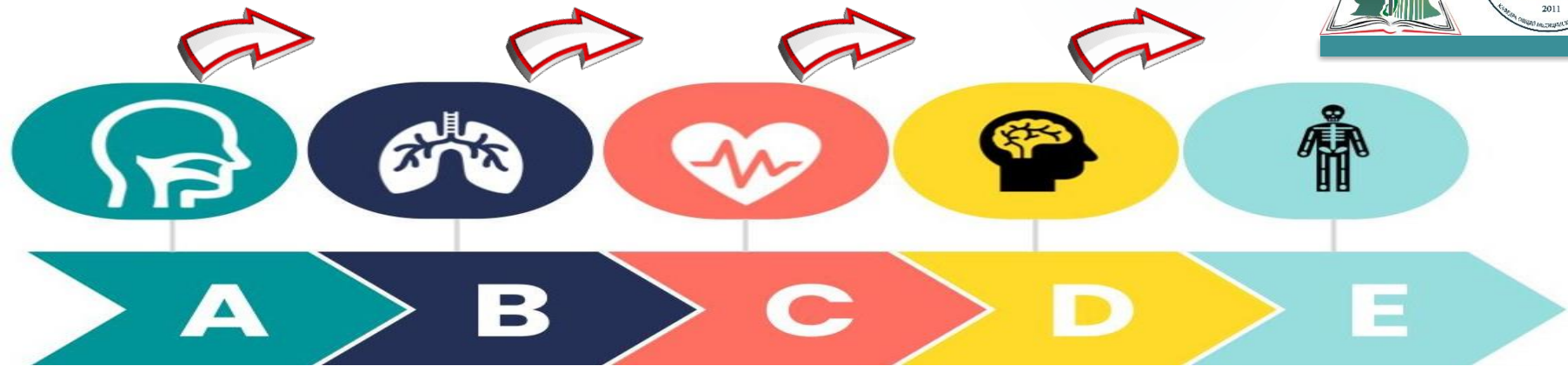
Оценка общего состояния и наблюдение за больным. Оценка сознания. Особенности оценки показателей основных жизненных функций. Антропометрические данные. Техника их определения. Мероприятия по обеспечению личной гигиены больного.

Оценка состояния пациента



**При выявлении патологического синдрома
дальнейшая оценка приостанавливается
до устранения жизнеугрожающего состояния**





Осмотр ДП

Пульсоксиметрия

Прием Геймлиха

Аспирация

Оксигенотерапия

Дыхание

ЧДД

Осмотр трахеи

Положение Фаулера

Пальпация

Перкуссия

Аускультация

Плевропункция

Ингаляция

ВИВЛ / ИВЛ

Центральный пульс

Периферический Ps

ЧСС

АД

Время рекапилляризации

Цвет кожи

Венозный доступ

ЭКГ

Анализы

Компрессии (СЛР)

Кровотечение

Положение

Тренделенбурга

Сознание
(ШКГ, FOUR, AVPU)

Зрачки (ФРЗ)

Менингознаки

Очаговая патология

Мышечный тонус

Глюкометрия

Полный осмотр

Кожа (сыпь, отеки)

Термометрия

Живот (пальпация)

Диурез

Повреждения

Первичный осмотр

Оценка общего вида



Используется только зрительная и слуховая информация

- ▶ **Внешний вид:** Мышечный тонус – достаточный, снижен, гипертонус, снижение реакция на обращение и утешение, страдальческое выражение лица, «поникий» взгляд, слабая речь/крик
- ▶ **Работа дыхания:** Увеличение работы дыхания (например, раздувание крыльев носа, втяжения), слабость или отсутствие попыток вдоха, ненормальные звуки (например, хрип, экспираторное хрюканье, свистящее дыхание)
- ▶ **Кровообращение:** Ненормальный цвет кожи (например, бледность или мраморность, синюшность – плохая перфузия и снижение оксигенации), гиперемия (лихорадка или интоксикация), кровотечение при травме

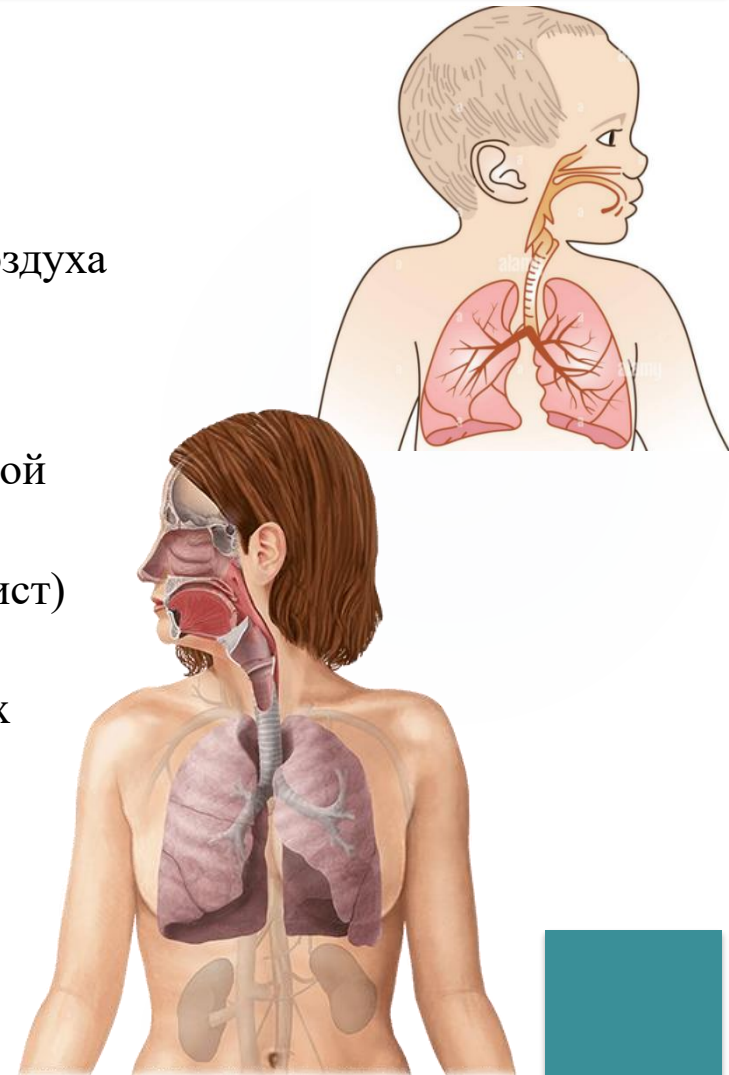
Airway

Дыхательные пути



Для оценки проходимости верхних дыхательных путей необходимо:

- ▶ Оценить движения грудной клетки и живота
- ▶ Установить наличие дыхательных шумов и движения воздуха
- ▶ Ощутить движение воздуха у рта и носа пациента
- ▶ Признаки обструкции верхних дыхательных путей:
- ▶ Увеличение респираторного усилия с втяжениями грудной клетки
- ▶ Патологические звуки во время вдоха (хрипение или свист)
- ▶ Отсутствие движения воздуха и дыхательных шумов, несмотря на попытки вдоха (полная обструкция верхних дыхательных путей)
- ▶ **Если человек может говорить – дыхательные пути проходимы!**



Простые меры для восстановления проходимости верхних дыхательных путей:



- ▶ Запрокидывания головы и выдвижения вперед нижней челюсти (Если нет подозрения на травму шейного отдела позвоночника).
- ▶ Выдвижение вперед нижней челюсти без запрокидывания головы (Если подозревается травма шейного отдела).
- ▶ Отсасывание содержимого из носоглотки и ротоглотки.
- ▶ Устранение обструкции дыхательных путей инородным телом у детей в сознании.



Breathing Дыхание



► Оценка дыхания включает определение:

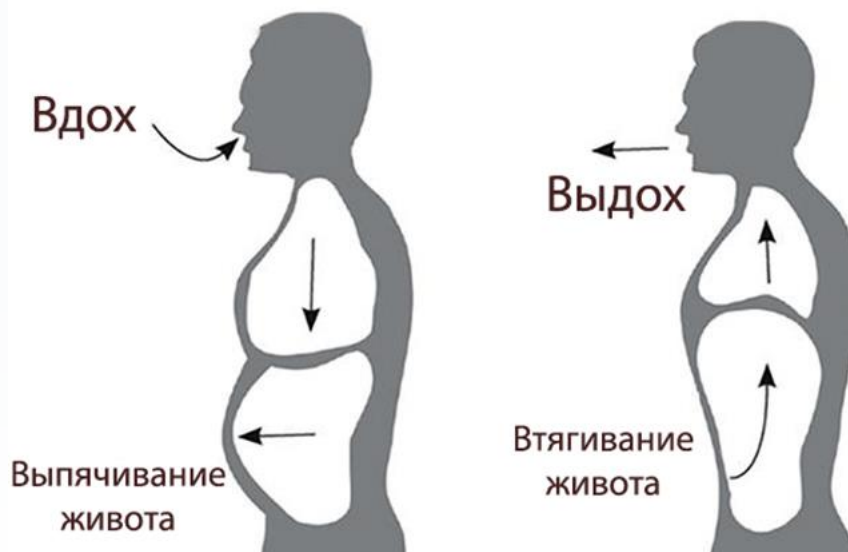
1. Частоты дыхания
2. Респиаторного усилия
3. Дыхательного объёма
4. Характера шумов в дыхательных путях и легких
5. SpO₂ (проведение пульсоксиметрии)

ЧД по возрасту:

1 год	30-53 в мин
1-3 года	22-37 в мин
4-5 лет	20-28 в мин
6-12 лет	18-25 в мин
13-18 лет	12-20 в мин

Пульсоксиметрия:

SpO₂ > 96%



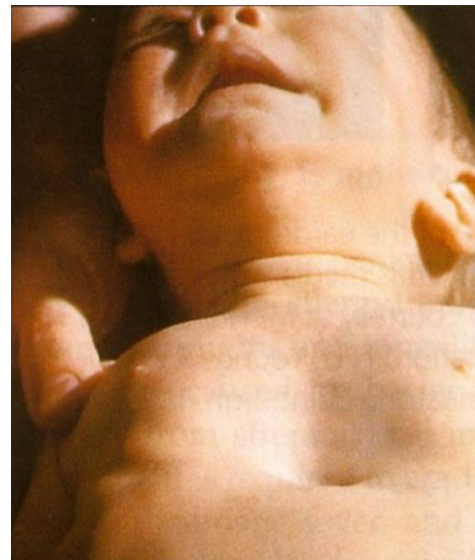
Нарушения работы дыхательной системы



Норма (эйпноэ)	
Тахипноэ	
Брадипноэ	
Апноэ	
Апнейзис	
Гаспинг	
Дыхание Чейн-Стокса	
Дыхание Грокка	
Дыхание Биота	
Дыхание Куссмауля	

Респираторное усилие

- Раздувание крыльев носа
- Втяжения грудной клетки
- Кивки головой или парадоксальное дыхание
- Удлинение вдоха или выдоха, дыхание ртом, хватание ртом воздуха и использование вспомогательной мускулатуры
- Экспираторное хрюканье



Circulation

Кровообращение

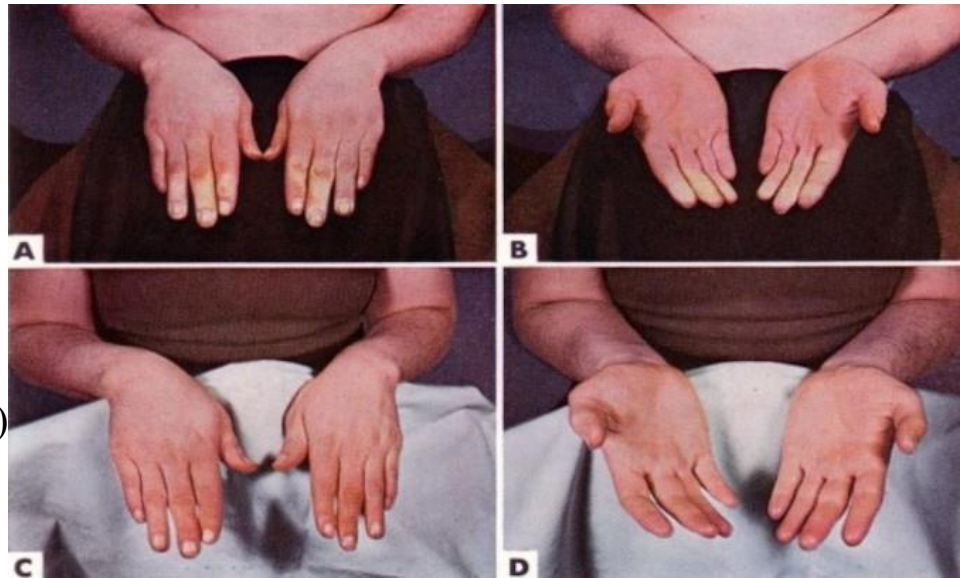


- ▶ Исследование кровообращения состоит из оценки функции как сердечно-сосудистой системы, так и органов-мишеней.
- ▶ При исследовании функции сердечно-сосудистой системы оцениваются:

1. **Цвет и температура кожи**
2. Частота сердечных сокращений
3. Сердечный ритм
4. Артериальное давление
5. Пульс (периферический и центральный)
6. Время заполнения капилляров

При исследовании функции органов-мишеней оцениваются:

1. Перфузия головного мозга (психический статус)
2. Почечная перфузия (диурез)



Disability

Неврологическое обследование

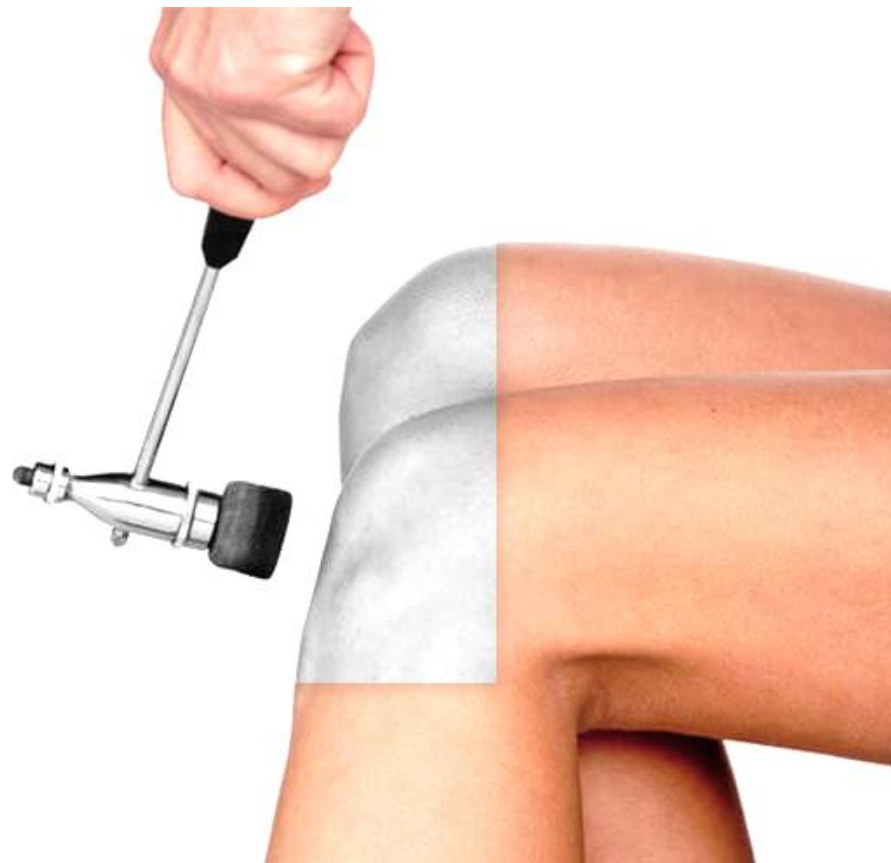


▶ **В стандартное неврологическое обследование входят:**

1. AVPU (педиатрическая шкала оценки реакции)
2. Шкала комы Глазго (GCS) / FOUR
3. Реакция зрачков на свет
4. Мышечный тонус
5. Менингеальные знаки

▶ **Причины снижения уровня сознания у детей включают:**

- Недостаточная перфузия головного мозга, например при повышении внутричерепного давления
- Травматическое повреждение головного мозга
- Энцефалит, менингит
- Гипогликемия
- Медикаменты и наркотики
- Гипоксемия
- Гиперкарбия



Шкала AVPU | БОБА



▶ **Alert** / активное **Бодрствование**:

«Адекватная реакция» определяется как реакция пациента, в т.ч. ребенка ожидаемая для возраста и окружающей обстановки.

▶ **Voice** / **Обращенная речь**:

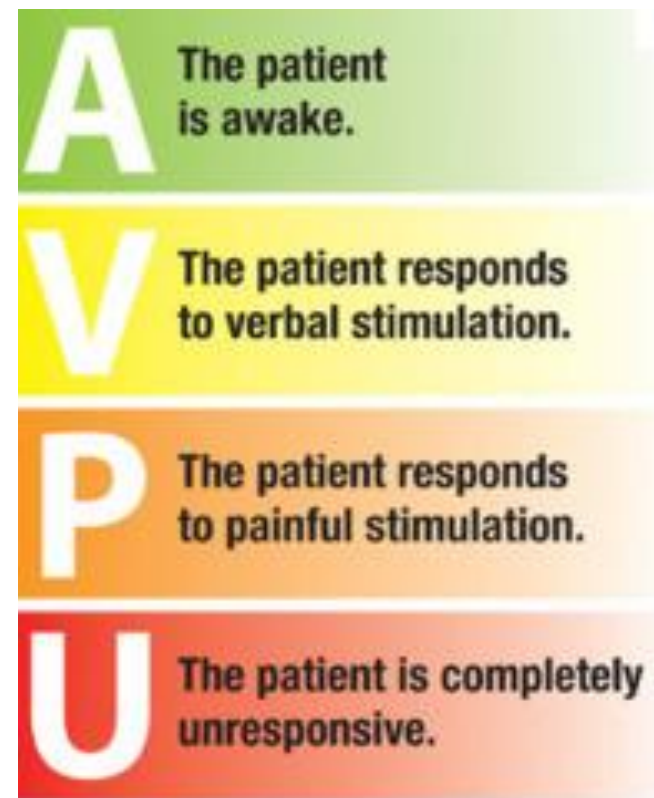
Пациент реагирует только если медицинский работник или родственник называет его имя или громко говорит

▶ **Painful** / **Боль**:

Пациент реагирует только на болевой раздражитель

▶ **Unresponsive** / **Арефлексия**:

Пациент не реагирует на любую стимуляцию



Шкала комы Глазго

для детей с 4-х лет и взрослых



ШКАЛА КОМЫ ГЛАЗГО (ШКГ)

ОТКРЫТИЕ ГЛАЗ



СПОНТАННОЕ	4
ПО ПРИКАЗАНИЮ	3
НА БОЛЕВОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ	2
ОТСУТСТВУЕТ	1

ВЕРБАЛЬНЫЙ ОТВЕТ



БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ	5
СПУТАННАЯ РЕЧЬ	4
БЕССМЫСЛЕННЫЕ СЛОВА	3
НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛЬ- НЫЕ ЗВУКИ	2
ОТСУТСТВУЕТ	1

МОТОРНЫЙ ОТВЕТ

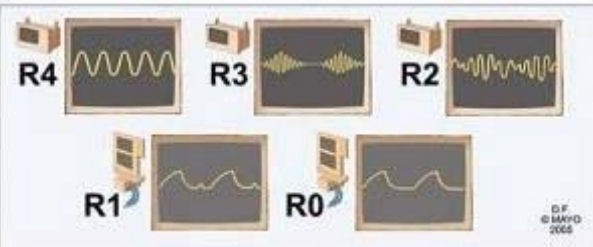
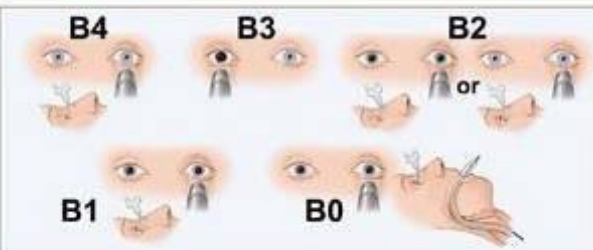
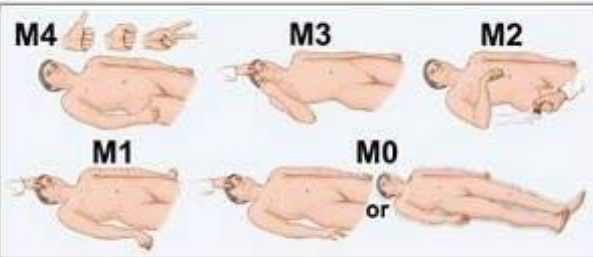


ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ В ОТВЕТ НА ИНСТРУКЦИЮ	6
ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛЕ- ВОГО РАЗДРАЖИТЕЛЯ	5
ОТДЕРГИВАНИЕ В ОТВЕТ НА БОЛЕВОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ	4
СГИБАНИЕ В ОТВЕТ НА БОЛЕВОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ	3
РАЗГИБАНИЕ В ОТВЕТ НА БОЛЕВОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ	2
ОТСУТСТВУЕТ	1

- ▶ 15 – ясное сознание
- ▶ 13-14 – оглушение (I, II)
- ▶ 9-12 – сопор
- ▶ 4-8 – кома
- ▶ 3 – смерть головного мозга

Шкала комы клиники Мейо (FOUR)

(Full Outline of UnResponsiveness)



Глазные реакции (E)
Двигательные реакции (M)
Стволовые рефлексы (B)
Дыхательный паттерн (R)

Интерпретация

16 - Ясное сознание
15 - Умеренное оглушение
13-14 - Глубокое оглушение (сомноленция)
9-12 - Сопор
7-8 - Кома I
1-6 - Кома II
0 - Кома III, гибель коры

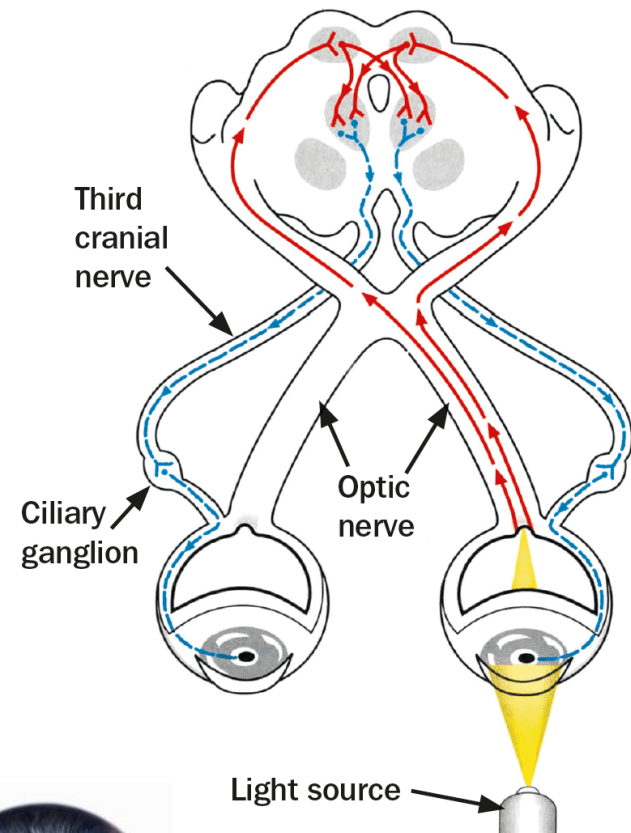
Wijdicks EF et al. Validation of a new coma scale: The FOUR score. Ann Neurol. 2005 Oct;58(4):585-93.

Реакция зрачков на свет



▶ Реакция зрачков на свет используется как показатель функции ствола мозга. **Если зрачки не суживаются при прямой световой стимуляции** (например, луч фонарика, направленный в глаза), **вы должны заподозрить повреждение ствола мозга.**

▶ Нарушения размера зрачка (анизокория) или реакции на свет могут встречаться в результате травмы глаза или в других условиях, например при повышении внутричерепного давления.



Мышечный тонус



У. УЛЫБКА



Попросите человека улыбнуться. Если улыбка не получается симметричной, это может быть следствием обездвиживания мышц лица в результате инсульта.

Д. ДВИЖЕНИЕ



Человека нужно попросить поднять руки. Если его движения не симметричны, это может говорить о поражении головного мозга.

А. АРТИКУЛЯЦИЯ

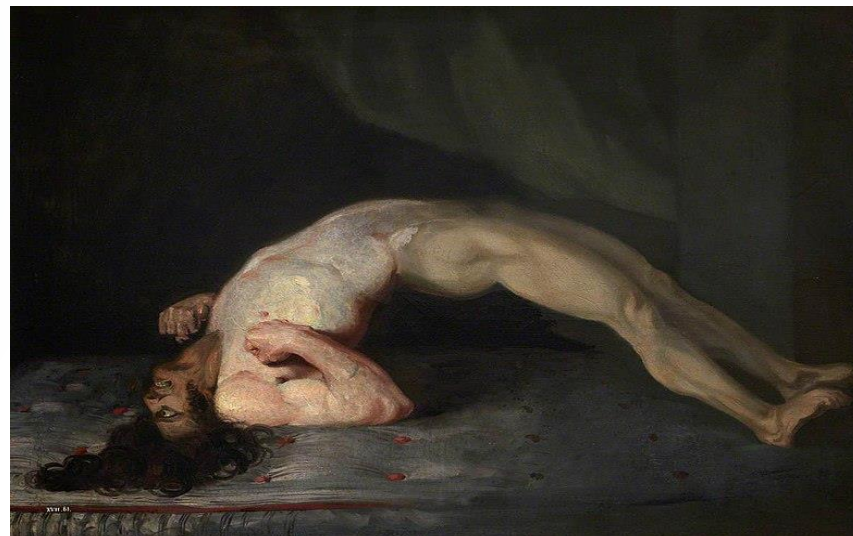


Неспособность внятно говорить – очень грозный симптом!

Р. РЕШЕНИЕ



Присутствие хотя бы одного из указанных симптомов указывает на инсульт в 75% случаев. В этом случае необходимо срочно вызывать «скорую»: счет времени идет на часы и минуты.

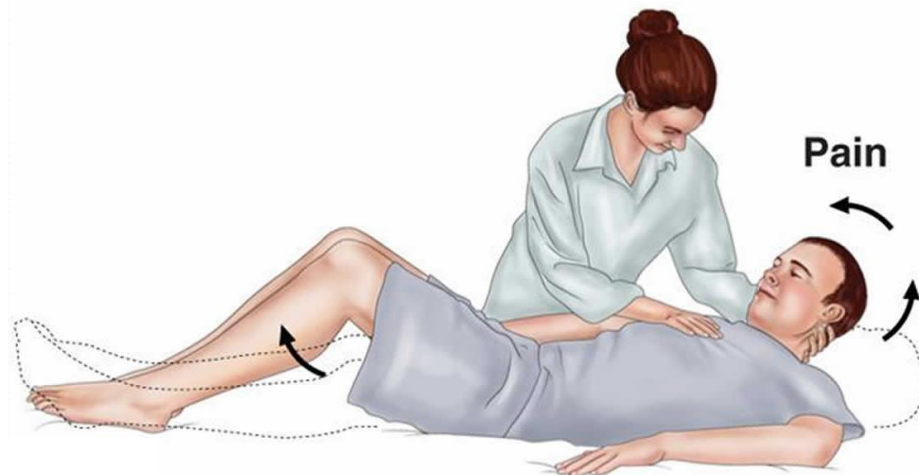


Опистотонус у пациента, страдающего столбняком
Ч. Белл, 1809

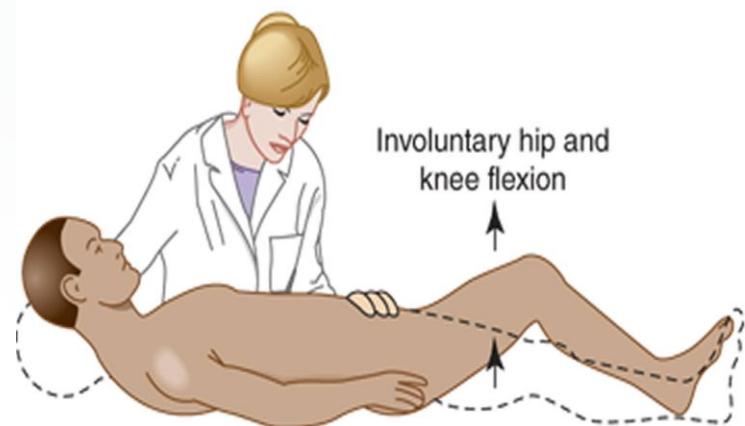
Менингеальные знаки



A Kernig sign



Brudzinski's Sign



B Brudzinski sign



Симптом Лессажа



Гликемия и нарушение сознания

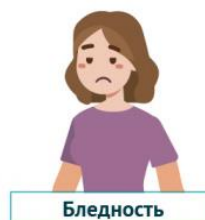


- ▶ Гипогликемия $< 3,5 - 2,8$ ммоль/л
- ▶ Нормогликемия $3,5 - 5,5$ ммоль/л
- ▶ Лёгкая гипергликемия $6,7 - 8,2$ ммоль/л
- ▶ средней тяжести $8,3 - 11,0$ ммоль/л
- ▶ тяжёлая свыше $15,1$ ммоль/л
- ▶ Прекома $> 16,5$ ммоль/л
- ▶ Кома $> 33,3$ ммоль/л

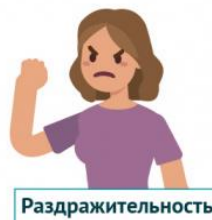
СИМПТОМЫ ГИПОГЛИКЕМИИ



Потливость



Бледность



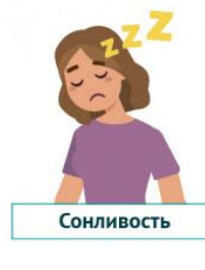
Раздражительность



Чувство голода



Недостаток
координации



Сонливость

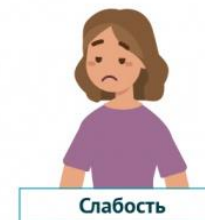
СИМПТОМЫ ГИПЕРГЛИКЕМИИ



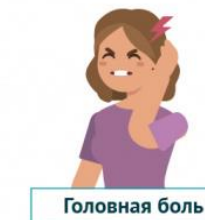
Сухость во рту



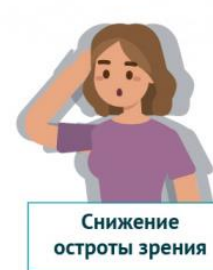
Жажда



Слабость



Головная боль



Снижение
остроты зрения



Частое
мочеиспускание



Exposure

Полный осмотр пациента



- ▶ Поочередно удаляйте одежду с обследуемых областей, чтобы внимательно осмотреть **лицо, туловище (переднюю и заднюю поверхности), конечности, и кожные покровы** пациента.
- ▶ Проведите термометрию. Согрейте пациента.
- ▶ Обратите внимание на травмы, видимые кровотечения, ожоги, признаки насилия.
- ▶ Работа мочевыделительной системы.
- ▶ Острый живот?



Вызов помощи, повторная оценка SAMPLE



Немедленно начните реанимационные мероприятия и сообщите в службу неотложной помощи в следующих условиях:

- ▶ Если у пациента имеется угрожающее жизни состояние
- ▶ Если вы не уверены или «чувствуете, что что-то не так»
- ▶ Если у ребенка нет угрожающего жизни состояния, начните проведение углубленного обследования.

Исследования второго порядка это SAMPLE

Символ	Значение	Перевод	Значение
S	Signs and symptoms	Признаки и симптомы	Симптомы, непосредственно предшествовавшие развитию критического
A	Allergies	Аллергия	Аллергологический анамнез
M	Medications	Лекарственные средства	Лекарственные препараты и иная терапия, проводимая пациенту
P	Pertinent past history	Значимые события в прошлом	Информация о наличии подобных симптомов в анамнезе и сопутствующих заболеваниях, проведенных обследованиях
L	Last oral intake	Последний прием пищи	Время последнего приема пищи и жидкости
E	Events leading up to the illness/injury	События, предшествовавшие заболеванию/травме	События, приведшие к заболеванию, травме



S <i>Symptoms</i>	DESCRIPTION Patient's chief complaints	QUESTIONS TO ASK - What's wrong? - What brought you to the hospital?
A <i>Allergies</i>	DESCRIPTION Seeking to know what type of allergic reaction they experience.	QUESTIONS TO ASK - Are you allergic to anything? - What happens to you when you use something that you're allergic to?
M <i>Medications</i>	DESCRIPTION Prescribed, OTC drugs, Herbal meds, etc.	QUESTIONS TO ASK - Are you taking any medications? - What are you taking the medications for? - When did you last take your medications?
P <i>Past Medical Hx</i>	DESCRIPTION Seeking to know the previous state of health, and previous illnesses.	QUESTIONS TO ASK - Have you had this problem before? - Do you have other medical problems?
L <i>Last Oral Intake</i>	DESCRIPTION Seeking what are the last oral intakes of the client.	QUESTIONS TO ASK - When did you last eat or drink anything? - What was it that you last ate?
E <i>Events</i>	DESCRIPTION Events leading up to the illness or injury.	QUESTIONS TO ASK - Injury: How did you get hurt? - Illness: What led to this problem?



- ▶ **Signs and Symptoms** – Симптомы и признаки (Изменение дыхания, Изменение уровня сознания, Возбуждение, беспокойство, Лихорадка, Ограничение способности к пероральному приему пищи, Понос, рвота, Кровотечение, Вялость)
- ▶ **Allergies** – Аллергические реакции (На лекарственные препараты, продукты питания, латекс и так далее)
- ▶ **Medications** – Медикаменты (Лекарственные препараты, Последняя дозировка и время последнего приема препаратов)
- ▶ **Past medical history** – История болезни
- ▶ **Last meal** – Последний прием пищи (Время последнего приема пищи или жидкости и ее характер)
- ▶ **Events** – Предшествующие события (События, приведшие к данной болезни или травме (например, внезапное или постепенное начало, тип повреждения), Факторы риска на месте происшествия, Лечение, проводимое от начала заболевания или момента травмы до настоящего времени, Предполагаемое время прибытия)





Антропометрия



Антропометрия



- ▶ От греч. *ἄνθρωπος* – человек и *μέτρον* – мерить – а один из основных методов антропологического исследования, заключающийся в измерении тела человека и его частей.
- ▶ Антропометрия – совокупность методов и приемов оценки морфологических особенностей человеческого тела.
- ▶ В медицине антропометрия используется при изучении физического развития человека, особенно – ребенка, так как служит **показателем роста и формирования детского организма**.
- ▶ При антропометрическом обследовании чаще всего измеряют рост / длину, массу, окружности головы и грудной клетки, размеры конечностей, отдельных частей туловища и другие показатели.

Измерение длины / роста

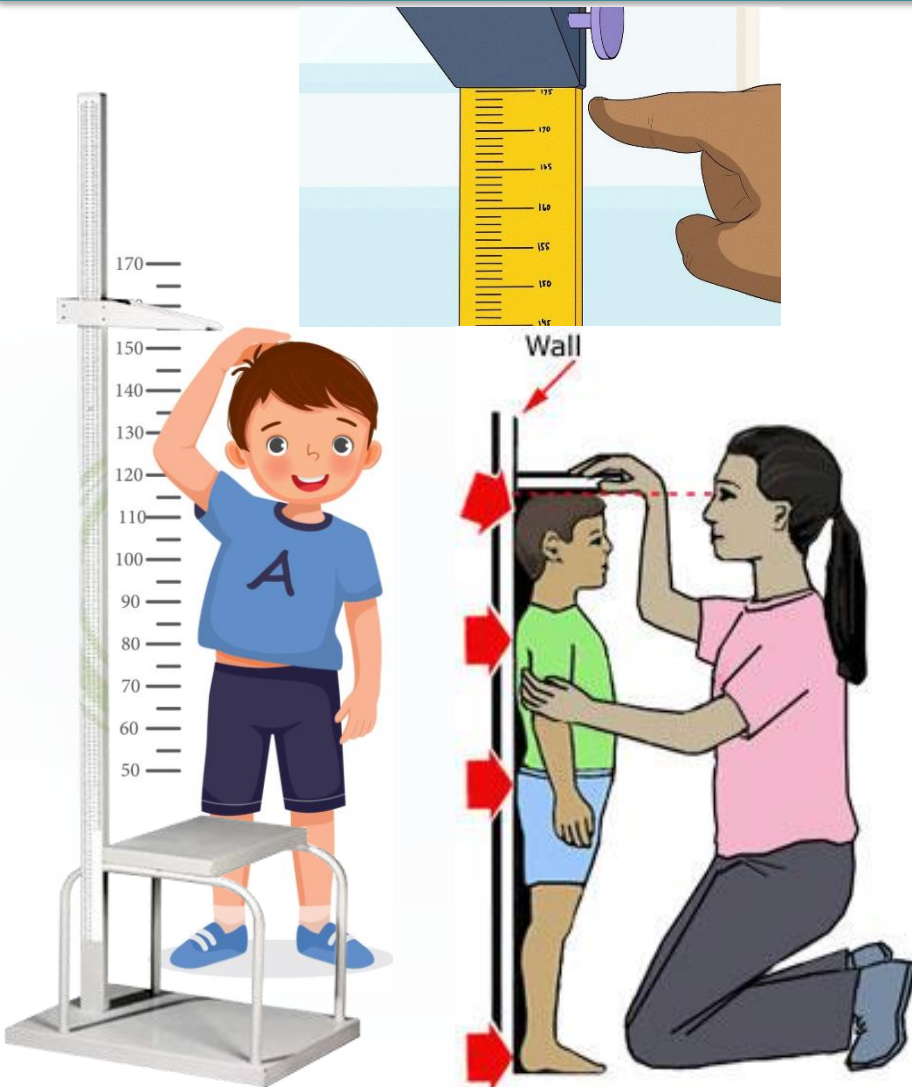


ГОЛОВА

- наружный угол глаза и козелок уха находятся на одной горизонтальной прямой, параллельной плоскости пола (классика);

- наружный угол глаза и верхний край прикрепления ушной раковины к височной области находятся на одной горизонтальной прямой, параллельной плоскости пола (реальность).

Точность измерений – 0,5 см





Измерение массы тела

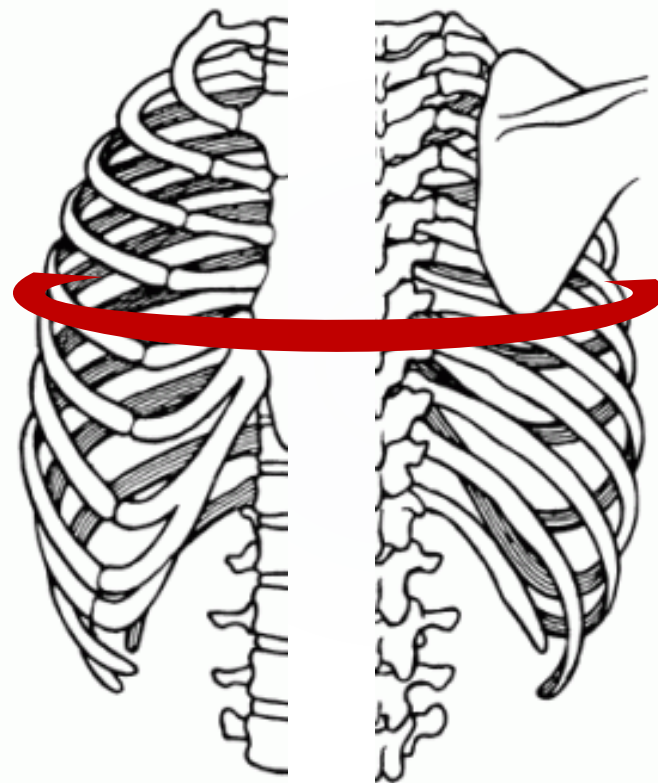
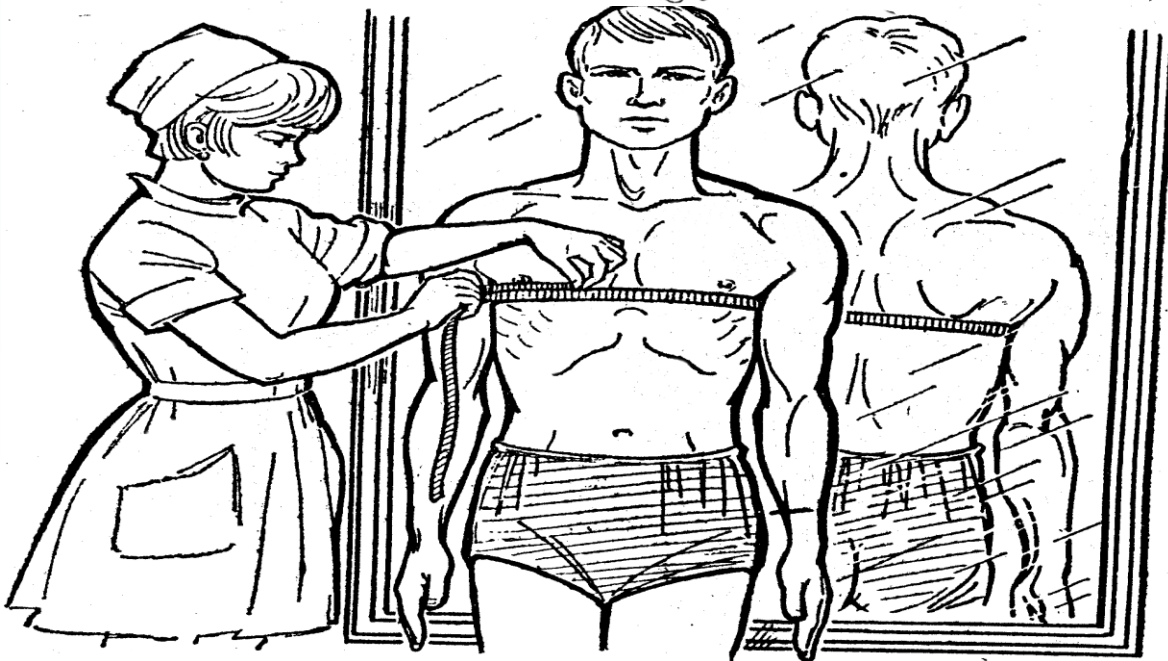


ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального обследования
Технология выполнения простой медицинской услуги функционального обследования ИЗМЕРЕНИЕ
МАССЫ ТЕЛА (A02.01.001)

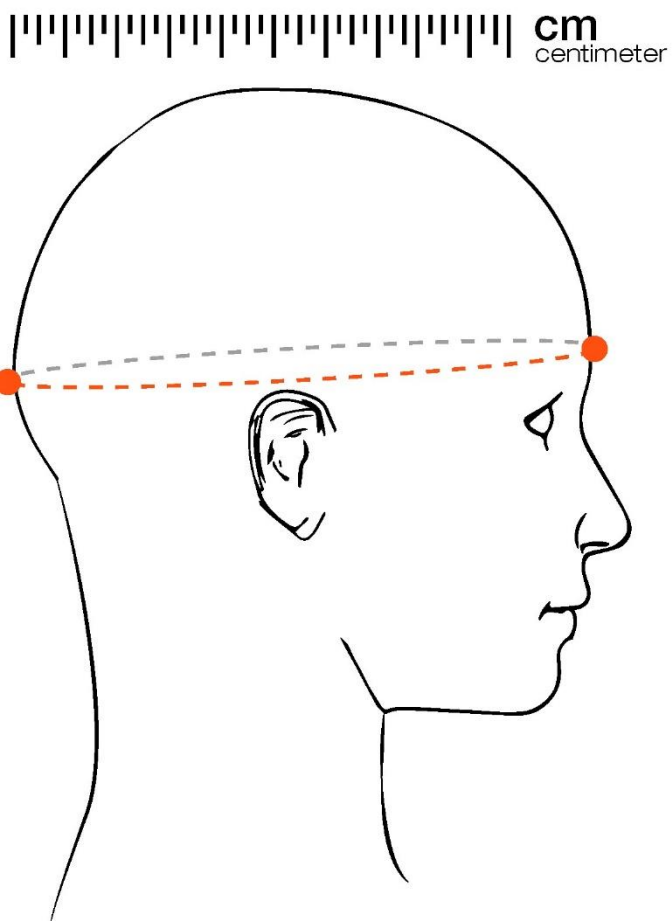
ОБНУЛЕНИЕ



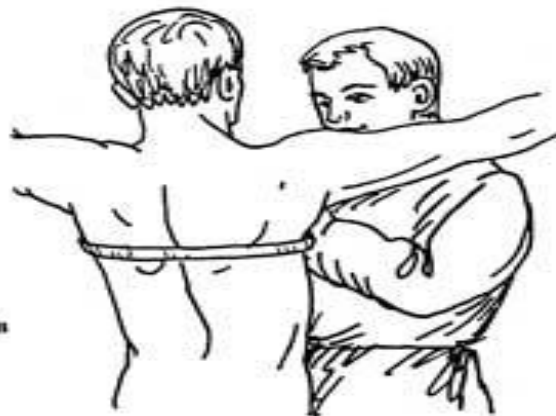
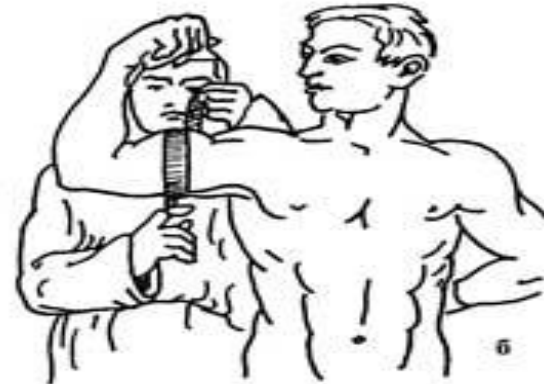
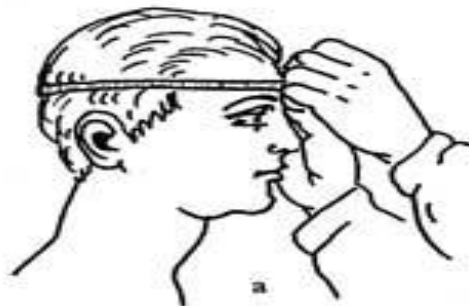
Измерение окружности груди



Измерение окружности головы



Измерение окружностей

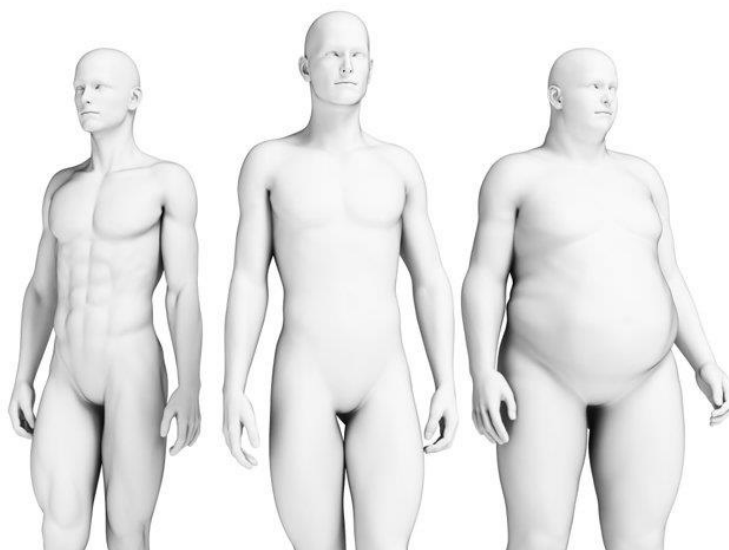


www.fiziolive.ru





Типы конституции (телосложения)



Определение типа конституции

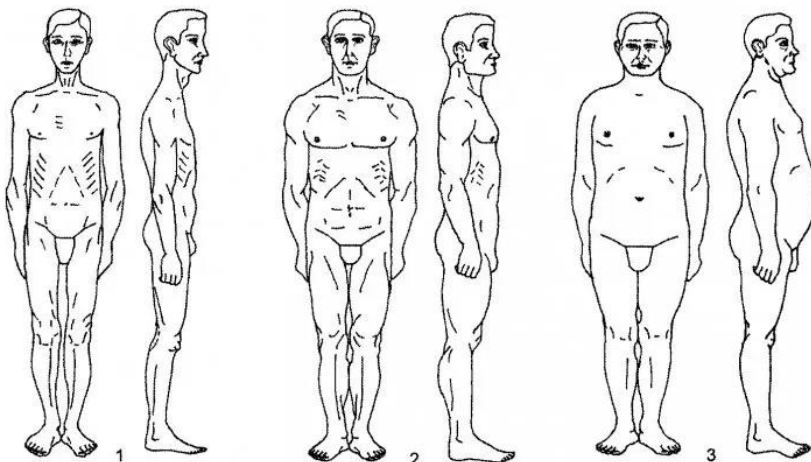


► Индекс Пинье = Рост (см) – Вес (кг) – Обхват груди (см)

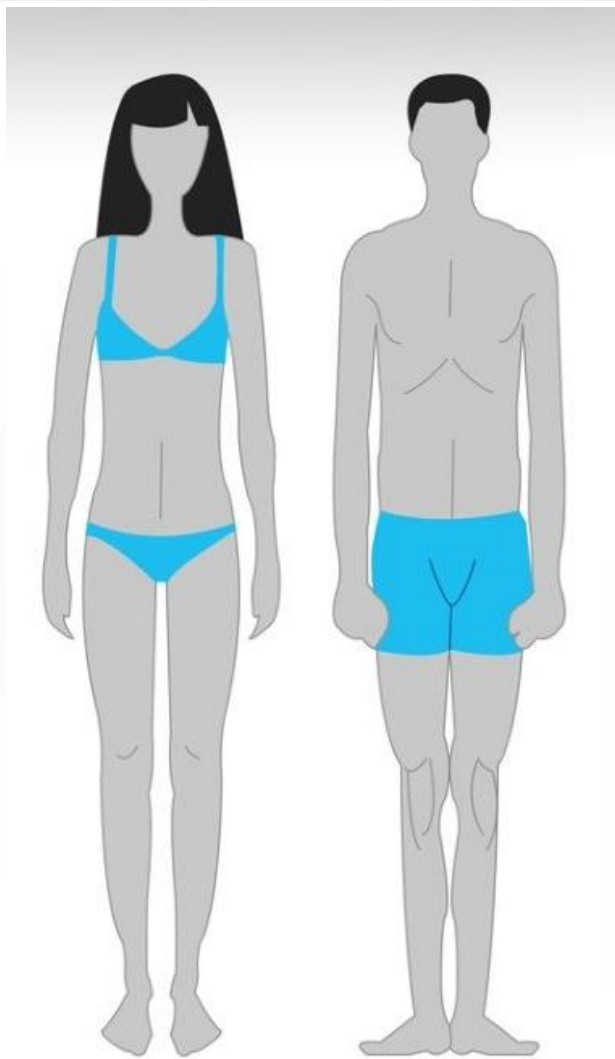
< 10	телосложение	крепкое
10-20		хорошее
21-25		среднее
26-35		слабое
> 36		очень слабое

► Индекс Соловьева = окружность запястья (см)

Тип телосложения	Мужчины	Женщины
Астенический	<18	< 15
Нормостенический	18 – 20	15 – 17
Гиперстенический	> 20	> 17



Астеники



- ▶ Стройность и легкость в строении тела и слабость общего развития.
- ▶ Конечности преобладают над относительно коротким туловищем, грудная клетка — над животом и продольные размеры — над поперечными.
- ▶ Тонкая и длинная шея, плоская грудная клетка, узкие плечи, удлиненные тонкие конечности, вытянутое лицо и тонкий нос.
- ▶ Сердце малой величины, легкие длинные и относительно большие, кишечник короткий, длинная брыжейка, низкое положение диафрагмы.
- ▶ Отличаются повышенной возбудимостью нервной системы.
- ▶ Предрасположены: птоз органов брюшной полости, язвенная болезнь, тяжелое течение туберкулеза легких, гипотония, патологическая аменорея, невроты

Нормостеники



- ▶ Пропорциональная фигура, стройные ноги, тонкая талия.
- ▶ Широкий плечевой пояс, выпуклая грудная клетка.
- ▶ Выраженный мышечный каркас.
- ▶ Рост обычно средний.
- ▶ Предрасположены: заболевания дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, невралгии.

Гиперстеники



- ▶ Массивное, длинное туловище и короткие конечности, преобладание живота над грудной клеткой и поперечных размеров над продольными.
- ▶ Кости широкие и тяжелые, крупные плечи, грудная клетка широкая и короткая, шея короткая.
- ▶ Относительно большое сердце, высокое положение диафрагмы, широкая аорта, легкие короткие, сравнительно малой величины, желудок объемный, кишечник длинный.
- ▶ Рост ниже среднего.
- ▶ Предрасположены: заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение, желчнокаменная болезнь.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА

АКТИВНОЕ



ПАССИВНОЕ



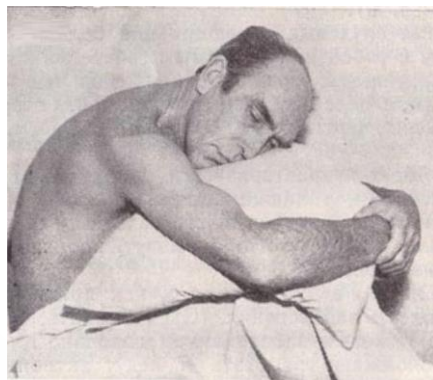
ВЫНУЖДЕННОЕ



Виды положения пациента в постели



- ▶ **Активное положение** — при удовлетворительном состоянии, когда пациент легко и свободно может осуществлять те, или иные, произвольные движения.
- ▶ **Пассивное положение** — в случаях невозможности активных движений больных (при бессознательном состоянии, резкой слабости)
- ▶ **Вынужденное положение** — пациенты принимают с целью уменьшения болезненных ощущений.





Поддержание гигиены тела пациента. Утренний туалет

Обязанностью медицинского сообщества является удовлетворение базовых потребностей человека

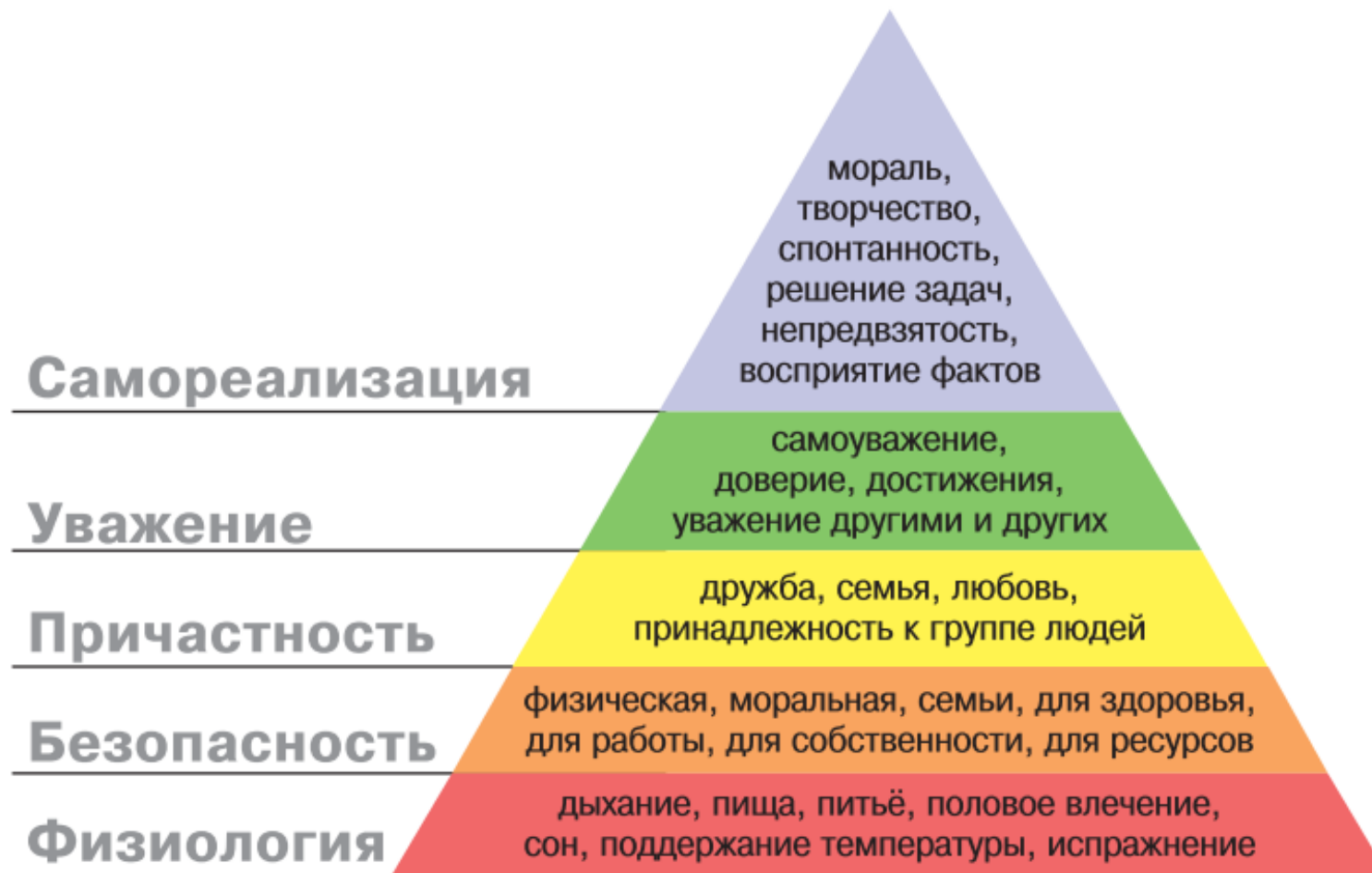


Рис. 1. Пирамида Маслоу

Общие понятия



Гигиена – медицинская наука, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни.

Личная гигиена (индивидуальная) – раздел гигиены, изучающий вопросы сохранения и укрепления здоровья человека, соблюдения гигиенических правил и мероприятий в его личной жизни и деятельности, разрабатываются и проводятся мероприятия гигиенического воспитания, пропаганда гигиенических знаний и здорового образа жизни в целях повышения гигиенической культуры населения.

В прикладном смысле, **личная гигиена** – это комплекс мер, направленных на поддержание чистоты тела и уход за ним.



Возможные последствия длительного постельного режима



- пролежни;
- атрофия мышц;
- запоры;
- мышечные контрактуры;
- почечные камни;
- застойные пневмонии;
- недержание мочи;
- гингивиты, стоматиты, парадонтоз;
- ухудшение слуха;
- синуситы;
- депрессивные состояния.



Принципы ухода за тяжелобольным



Цель помощи – помощь в поддержании гигиены тела, профилактика развития инфекционных и трофических осложнений, обеспечение комфорта.

Принципы ухода

**Безопас-
ность**

предупреждение
травматизма
пациента

**Конфиден-
циальность**

подробности
личной жизни не
должны быть
известны
посторонним

**Уважение
чувства
достоинства**

выполнение всех
процедур с согласия
пациента,
обеспечение
удинения , если
необходимо

Общение

расположение
пациента и членов
его семьи к беседе,
обсуждение хода
предстоящей
процедуры и плана
ухода в целом

**Независи-
мость**

поощрение
каждого пациента
к
самостоятельности

**Инфекцион-
ная
безопасность**

осуществление
соответствующих
мероприятий

Рекомендации по уходу за тяжелобольным



Рекомендации при дефиците личной гигиены больного:

- оценить способность самоухода;
- уточнить степень участия и предпочтения;
- побуждать и поощрять пациента на самостоятельные действия;
- оказать помощь пациенту в проведении туалета тела;
- помощь при подмывании, мытье головы;
- своевременная смена нательного и постельного белья.

Общие рекомендации по уходу за тяжелобольным

- Больной – остается личностью со своим характером и интересами!
- Поместите, если возможно, больного в отдельную комнату или выделите ему место у окна;
- Доступ к кровати со всех сторон;
- Рядом с постелью кроватью поставить тумбочку и стул;
- Звонок вызова медсестры в зоне досягаемости;
- Застежки и завязки одежды больного должны быть спереди;
- Проветривайте комнату больного 5–6 раз в день в любую погоду на 15–20 минут, укрыв больного;
- Активизация пациента (при возможности)

- Гигиенический уход за тяжелобольными проводится утром, а также после приема пищи и при загрязнении тела.
- Периодически должны быть организованы стрижка и бритье больных.
- Чем тяжелее больной, тем сложнее за ним ухаживать, труднее выполнять любые манипуляции по уходу за полостью рта, ушами, глазами, носом и т.п.

Общий алгоритм ухода за тяжелобольным



**Учитывая
основные
принципы
ухода за
пациентом,
подготовка и
окончание
процедуры
включает
следующие
этапы**

Объяснить пациенту суть и ход предстоящей процедуры.

(объяснять необходимо в доступной для пациента форме, такой разговор помогает снять эмоциональное напряжение, создать доверительную обстановку, мотивирует пациента к сотрудничеству)

Получить согласие пациента на проведение процедуры.

(соблюдаются права пациента на информацию)

Обеспечить пациенту конфиденциальность (отгородить ширмой).

(соблюдение основных принципов ухода)

Вымыть и осушить руки.

(соблюдение инфекционной безопасности)

Подготовить необходимое оснащение.

Использовать перчатки

(соблюдение инфекционной безопасности)

Объем независимых сестринских вмешательств



- ▶ процедуры личной гигиены (смена постельного и нательного белья, гигиена кожи, утренний туалет);
- ▶ общая гигиена помещений (генеральная уборка процедурного кабинета, проветривание палат, кварцевание);
- ▶ удовлетворение физиологических потребностей (кормление пациента, прием адекватного количества жидкости);
- ▶ удовлетворение физиологических отправления (подача судна, мочеприемника);
- ▶ общение с пациентом, его родственниками по вопросам здорового образа жизни, личной гигиены, досуга.

Умывание пациента



Целью умывания пациента является поддержание личной гигиены.

Показанием для этой процедуры будет дефицит или невозможность самоухода, а также тяжелое состояние пациента.

Оснащение:

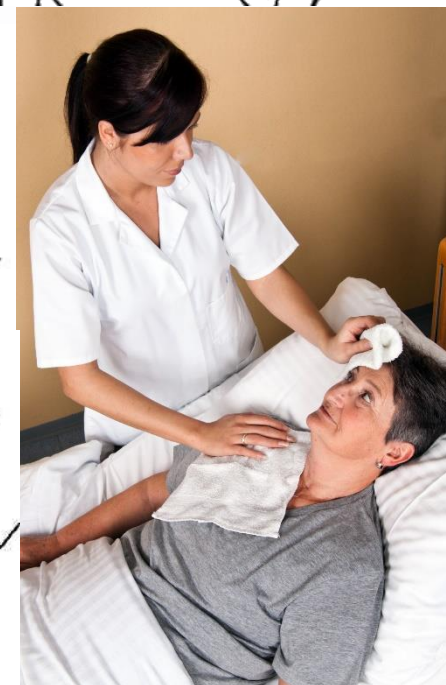
1. емкость с теплой ($35-37^{\circ}\text{C}$) водой,
2. полотенце,
3. махровая рукавичка,
4. клеенка,
5. пеленка.



Выполнение процедуры



1. Придать пациенту положение Фаулера, накрыть ему грудь пленкой;
2. Взять в руки полотенце (махровую рукавицу), половину его смочить в емкости с теплой водой, отжать;
3. Протереть лоб, веки, щеки, нос, подбородок, шею пациента
4. Осушить второй половиной полотенца лицо и шею пациента в той же последовательности мягкими промокательными движениями
5. Снять пленку с груди пациента, положить в мешок для использованного белья
6. Помочь пациенту занять удобное положение.
7. Убедиться, что пациент чувствует себя комфортно



Бритье



- ▶ Смочить салфетку в воде, отжать и положить её на щёки и подбородок пациента на 5-10 мин (или смочить лицо).
- ▶ Осмотреть лицо для выявления родинок, родимых пятен, очагов воспаления (эти места нужно «обходить»).
- ▶ Нанести на кожу лица крем или пену для бритья, равномерно распределить его с помощью помазка.
- ▶ Вести станок вниз, оттягивая кожу кверху; брить сначала одну щеку, потом под носом, затем другую щеку, под нижней губой и область шеи под подбородком.
- ▶ Смочить салфетку водой, отжать её и протереть кожу лица.
- ▶ Осушить кожу лица сухой салфеткой легкими промокательными движениями и смочить кожу лосьоном.
- ▶ Дать зеркало, чтобы пациент мог увидеть себя.

Уход за полостью рта и зубами



- Несвоевременная гигиена полости рта может привести к появлению запаха изо рта, воспалительным процессам: стоматиту, гингивиту, кариесу.
- Слизистая оболочка полости рта может быть раздражена или иметь налет у ослабленных и лихорадящих пациентов. Налет состоит из слизи, слущенных клеток эпителия, бактерий, разлагающихся остатков пищи.
- Ежедневный осмотр и проведение гигиенических процедур полости рта помогут создать и поддержать комфорт пациенту.

Если пациент в сознании

- оказать помощь в уходе за полостью рта

Если пациент беспомощен

- полоскание рта после каждого приема пищи / приступа рвоты;
- чистка зубов (зубных протезов) вечером и утром;
- очищение промежутков между зубами 1 раз в день (лучше вечером).



Уход за полостью рта



- ▶ **Часто пациенты без сознания не могут глотать слюну.** Скопление слюны провоцирует развитие бактериальных осложнений.
- ▶ Уход за полостью рта у таких больных необходимо каждые 2 ч
- ▶ **Выполнение процедуры:**
 1. Приготовить мягкую зубную щетку для чистки зубов / марлевую салфетку на зажиме или палочке.
 2. Салфеткой, смоченной в антисептическом растворе, протереть язык, снимая налет, в направлении от корня языка к его кончику.
 3. Салфеткой, смоченной в антисептическом растворе, протереть внутреннюю поверхность щек, пространство под языком, десны пациента. Повторить не менее 2-х раз.
 4. Сухими тампонами промокнуть ротовую полость пациента.
 5. При сухости языка смазать его стерильным глицерином.
 6. Обработать последовательно верхнюю и нижнюю губы тонким слоем вазелина (для профилактики трещин на губах).



Промывание полости рта



- ▶ Промывание полости рта проводят с помощью шприца, резинового баллона, кружки Эсмарха (предложена немецким врачом Фридрихом фон Эсмархом (1823-1908)) с резиновой трубкой и стеклянным наконечником.
- ▶ Порядок выполнения процедуры:
 1. Подготовиться к проведению процедуры: разложить необходимое оснащение, надеть перчатки.
 2. Набрать в кружку Эсмарха тёплый антисептический раствор и подвесить её на 1 м выше головы больного.
 3. Голову больного повернуть набок (иначе он может захлебнуться!), шею и грудь прикрыть клеёнкой, к подбородку подвести лоток.
 4. Оттянуть угол рта шпателем, ввести наконечник в преддверие рта и струёй жидкости под умеренным давлением промыть его.
 5. Промыть поочерёдно левое, затем правое защёчное пространство (щеку оттягивать шпателем).
 6. Аспирировать раствор с помощью электроотсоса (или самостоятельно пациент)
 6. Снять перчатки, вымыть руки.



Уход за зубами



- ▶ Для чистки зубов лучше использовать зубную пасту, содержащую фтор, укрепляющий эмаль зубов и препятствующий развитию кариеса.
- ▶ Зубная щетка должна быть мягкой, не травмирующей десну.
- ▶ Нитью для очищения промежутков между зубами нужно пользоваться, не прилагая значительных усилий, поскольку это может привести к повреждению десен и кровоточивости.
- ▶ Завершая уход за полостью рта, обязательно очистить щеткой язык, снимая с него налет, содержащий бактерии.
- ▶ При невозможности прополоскать рот, необходимо использовать аспиратор для удаления жидкостей.

Средства гигиены полости рта:

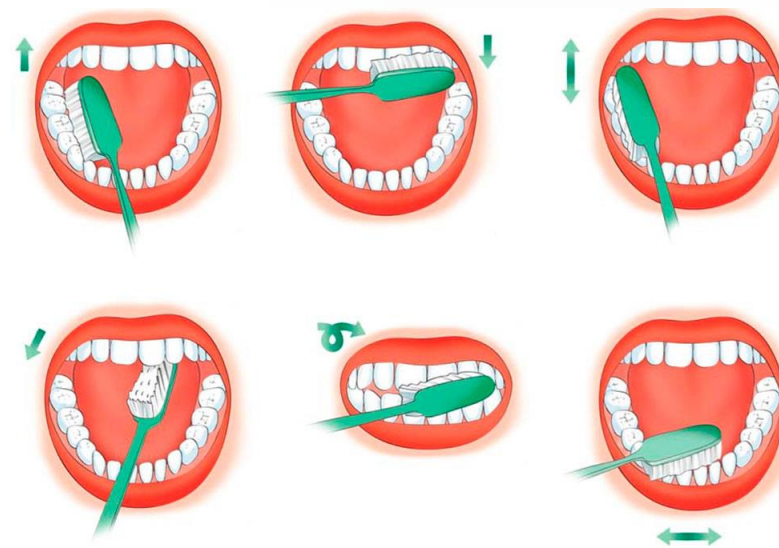
- Зубные щетки
- Зубочистки
- Флосс (зубная нить)
- Зубные пасты.
- Зубные эликсиры



Порядок чистки зубов



Не менее 2-х минут
2 раза в день и
После каждого приема пищи



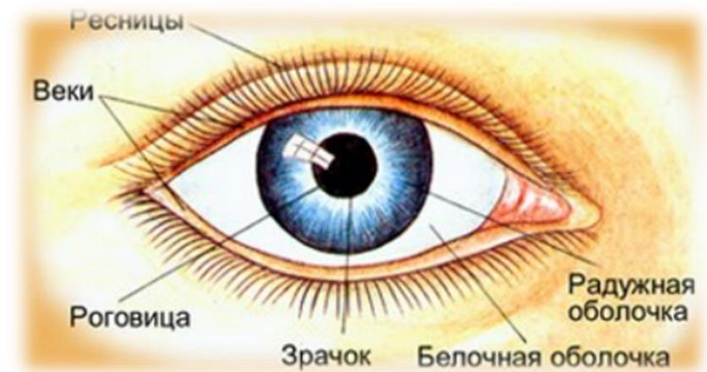
Уход за зубными протезами



- Чистить протезы после каждого приема пищи и не реже 2-х раз в день;
- Очищать поверхность зубной щеткой с мягкой щетиной и специальной зубной пастой (или детским мылом);
- Не реже 2 раз в неделю необходима обработка специальными дезинфицирующими средствами;
- Замачивать протезы на ночь в отдельной емкости;
- Не использовать горячую воду;
- Не высушивать протезы;
- Позволить в течение дня находиться в протезе (лучше дикция)



Уход за глазами

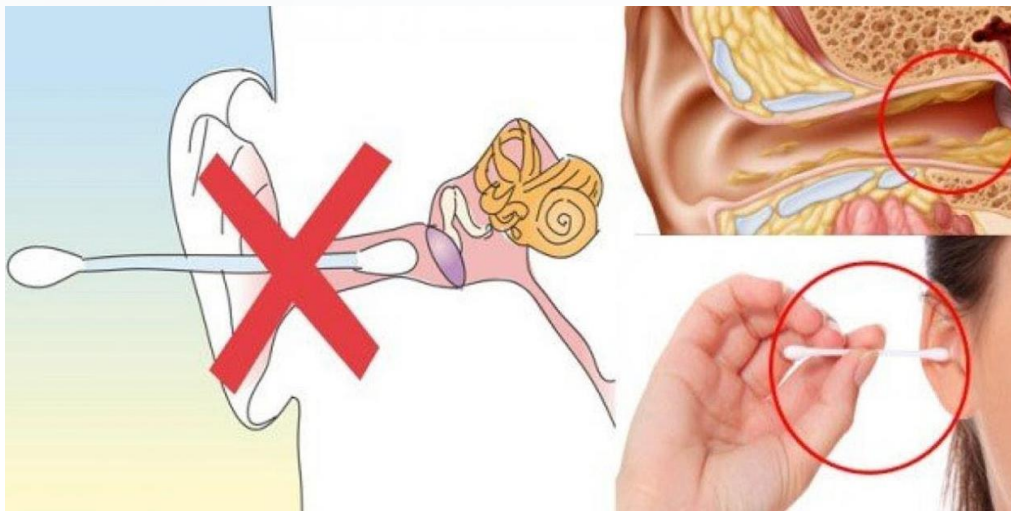
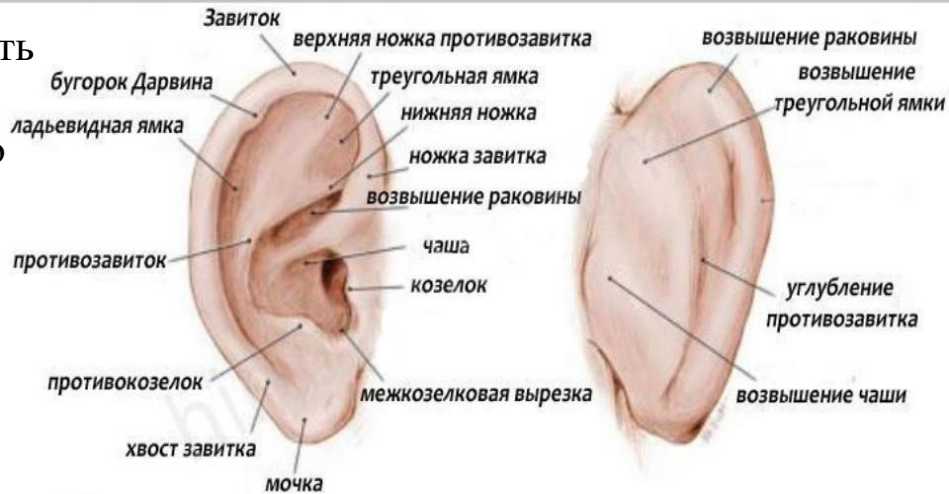


- Туалет глаз осуществляется не реже 2 раз в день и при необходимости (выделения);
- Используются салфетки (тампоны) с водорастворимым раствором антисептика;
- Отдельные салфетки (4 – 6) для каждого глаза;
- Направление движений «от уха к носу»

Уход за ушами



- Избыточное количество серы может образовывать серные пробки (шум в ушах, снижение слуха).
- **Уход за здоровыми ушами** требует регулярного мытья ушной раковины и наружного слухового прохода теплой водой с мылом.
- Нельзя чистить наружный слуховой проход острыми предметами, которые могут повредить барабанную перепонку или стенку слухового прохода (в т.ч. ватной палочкой).
- Серную пробку удаляет врач.

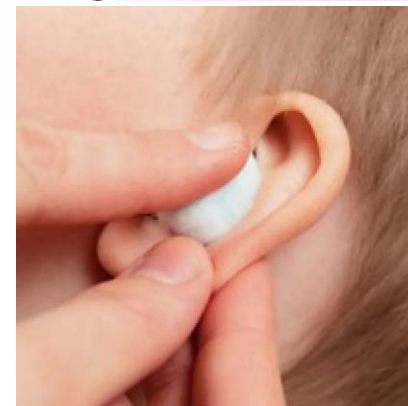


Уход за ушами



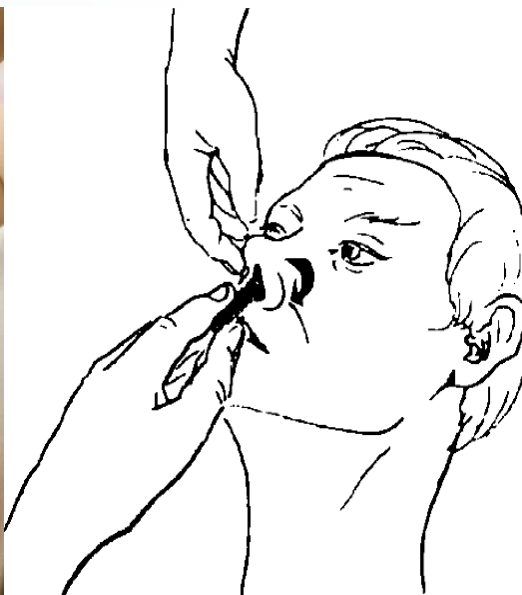
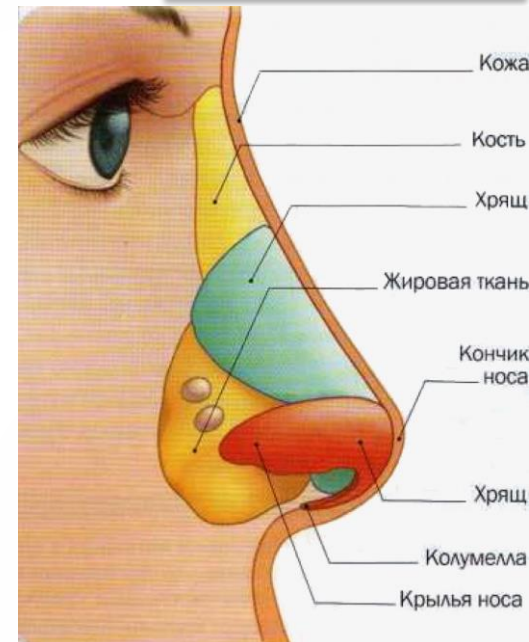
► Выполнение процедуры

1. Помочь пациенту занять удобное положение.
2. Прикрыть его шею и плечо полотенцем
3. Надеть перчатки
4. Попросить пациента наклонить голову в сторону, противоположную обработке
5. Набрать в пипетку 3 % раствор перекиси водорода. Оттянуть левой рукой ушную раковину назад и вверх. Правой рукой закапать в наружный слуховой проход 2—3 капли. Оставить пациента в таком положении на 1—2 мин.
6. Ввести в слуховой проход вращательными движениями сухую турунду, оттянув при этом ушную раковину назад и вверх. Вывести турунду обратно.
7. Повторить процедуру несколько раз, меняя турунды
8. Обработать влажным тампоном, смоченным в теплой воде, ушную раковину, затем тщательно просушить ее сухими ватными тампонами. Сбросить использованные тампоны в лоток для последующей утилизации
9. Обработать другое ухо таким же образом
10. Помочь пациенту занять положение, удобное для пребывания в постели.
11. Убедиться, что пациент чувствует себя комфортно



Уход за носом

- ▶ Не реже 1 раза в день.
- ▶ Объяснить пациенту цель процедуры, получить согласие;
- ▶ Взять турунду пинцетом, смочить в вазелиновом масле / глицерине, слегка отжать.
- ▶ Ввести вращательными движениями в носовой ход на 4-6 см на 1-3 минуты, приподнимая кончик носа пациента.
- ▶ Извлечь турунду вращательными движениями из носового хода.



Уход за волосами



► Необходимо расчёсывать волосы несколько раз в день. Щётка или расческа должны быть с затупленными, лучше редкими зубьями, чтобы не поранить голову и не причинить боль.

► Легче расчёсывать волосы, когда пациент сидит. Расчёсывая лежачего пациента следует повернуть его голову в одну, затем в другую сторону.

► Не реже 1 раза в неделю необходимо мыть голову и волосы.



Стрижка волос



► Необходимое оснащение:

1. Ножницы, машинка для стрижки волос.
2. Таз для сжигания волос, спички.
3. Спиртовой раствор антисептика.

► Порядок выполнения процедуры:

1. Подготовиться к проведению санитарно-гигиенической обработки: разложить необходимое оснащение.
2. Постелить на табуретку (кушетку) клеёнку, усадить на неё больного и покрыть ему плечи полиэтиленовой пелёнкой.
3. Снять волосы машинкой для стрижки волос, при кожном заболевании волосистой части головы – остричь волосы над подготовленным тазом.
4. Сжечь волосы / утилизировать в отходы класс Б.
5. Обработать ножницы, бритву.

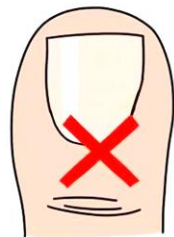
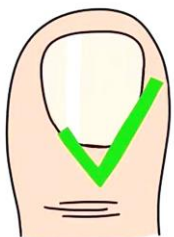


Уход за ногтями

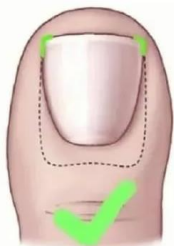


Больные еженедельно должны стричь ногти на пальцах рук и не реже 2 раз в месяц на пальцах ног.

1. Добавить в лоток с тёплой водой жидкое мыло и опустить в него на 2–3 мин кисти / стопы пациента (поочерёдно по мере обрезки ногтей).
2. Поочерёдно извлекая пальцы пациента из воды, вытирать их и аккуратно подрезать ногти.
3. Обработать руки / стопы пациента кремом.
4. Протезинфицировать ножницы и щипчики раствором антисептика.



Руки



Ноги



Уход за промежностью



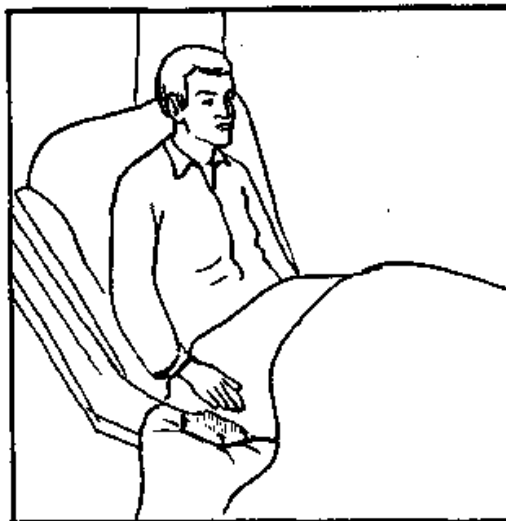
- ▶ Использование индивидуальных / одноразовых гигиенических средств;
- ▶ Чрезмерное увлечение мылом и сильное трение кожи наружных половых органов могут привести к возникновению воспалительных процессов кожи;
- ▶ Мыть гениталии достаточно 2 раза – утром и вечером, а также после опорожнения (у женщин – после каждого мочеиспускания).
- ▶ Естественные складки у тучных людей при увлажнении обрабатывают присыпкой, при сухости кожи используют увлажняющий крем.



ООО "Медика-Крым"



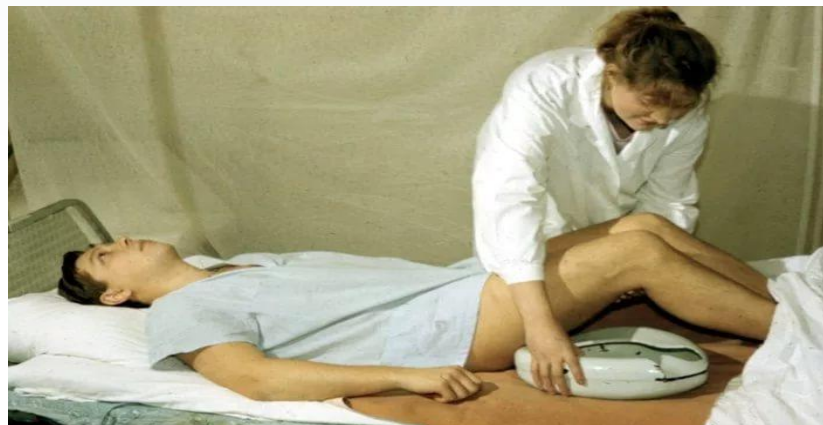
Уход при ограниченной подвижности



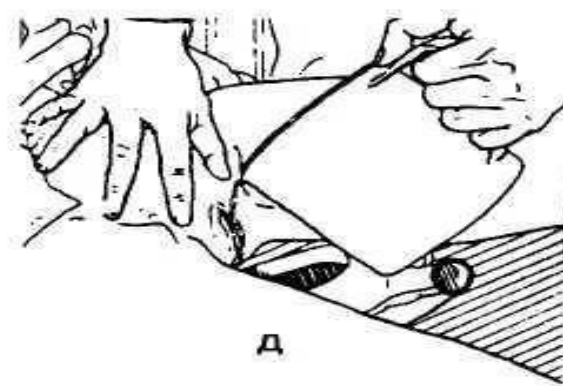
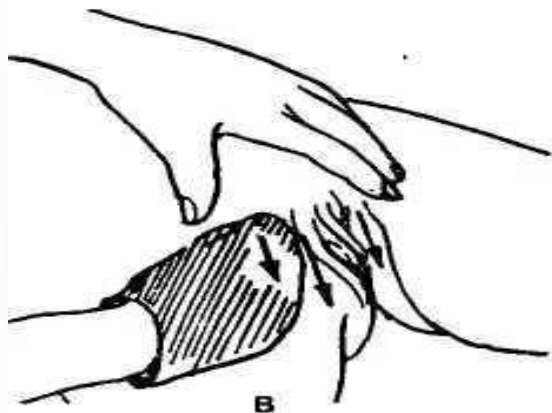
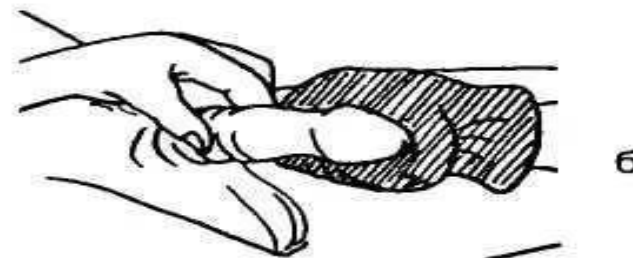
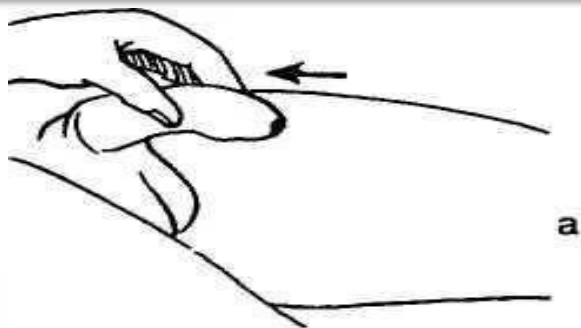
д



е



Уход за промежностью: мужчины



Аккуратно отодвинув пальцами левой руки крайнюю плоть, обнажают головку полового члена, **обрабатывают** его, а также кожу полового члена, мошонку, паховые складки, область заднего прохода, межъягодичную складку, меняя салфетки по мере загрязнения. Просушивание проводят в той же последовательности.

От мочеиспускательного канала к мошонке

Уход за промежностью: женщины

- ▶ Пациентке приподнимают таз, под крестец подкладывают судно, оставляют, прикрыв одеялом;
- ▶ Для гигиенических мероприятий необходимо встать сбоку, взяв в одну руку емкость с теплой водой, а в другую руку – зажим с марлевым тампоном (салфеткой).
- ▶ Поливая из емкости на половые органы, следует последовательно обрабатывать их по направлению от лобка к анальному отверстию: область лобка, наружные (большие) половые губы, паховые складки, промежность, область анального отверстия, межъягодичную складку.
- ▶ Салфетки меняют по мере загрязнения.
- ▶ По окончании процедуры части тела просушивают марлевыми салфетками (тампонами) в той же последовательности.



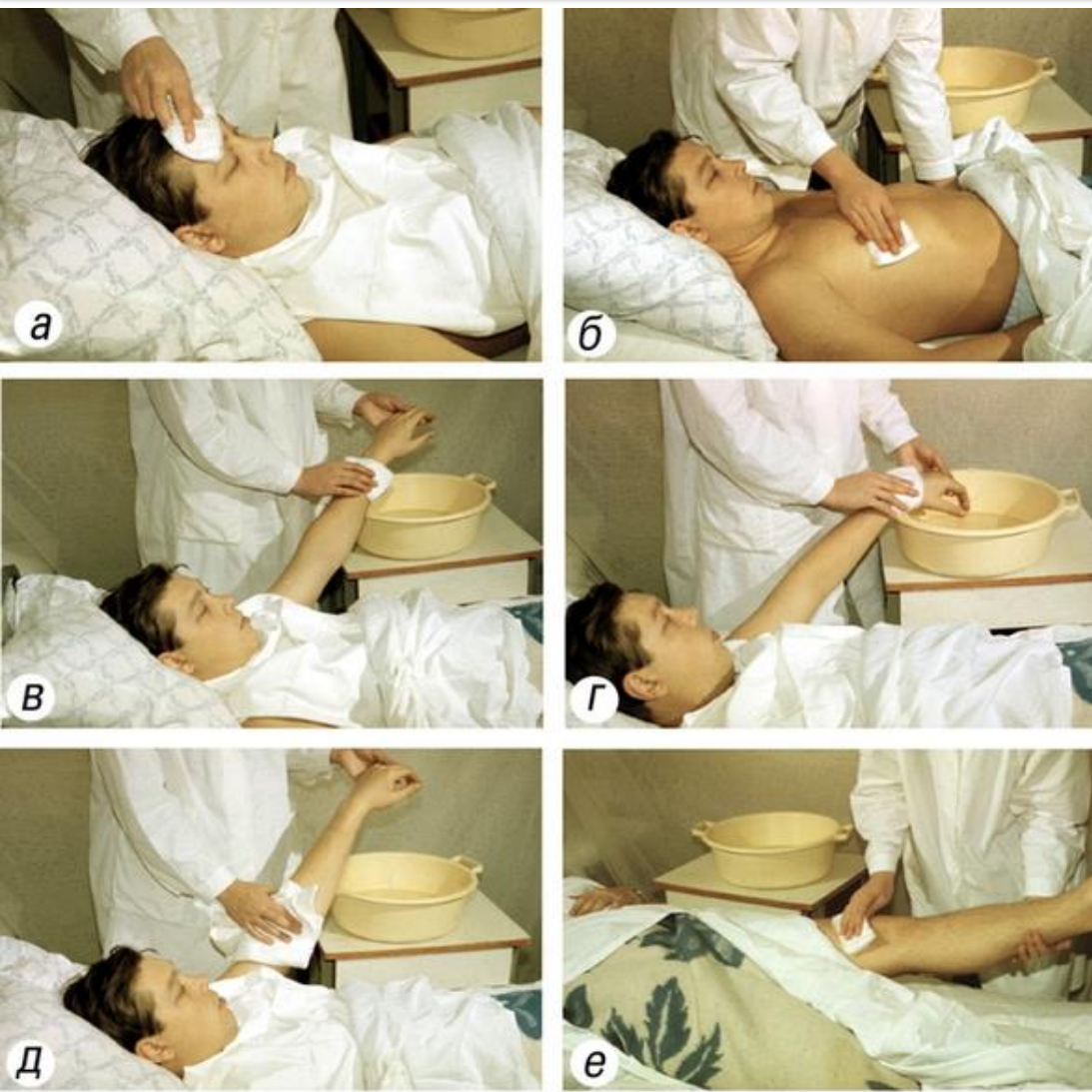
Уход за промежностью



- Проводится ежедневно, по мере загрязнения, регулярно, но не менее двух раз в день;
- Проводится с целью предотвращения развития пролежней, контактного дерматита ассоциированного с недержанием мочи и кала;
- Проводится с помощью профессиональных средств, медицинских изделий для ухода за кожей
- Используется абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки), подгузники, впитывающие трусы, урологические прокладки и вкладыши и др.), препятствующие увлажнению кожи, уменьшающие ее инфицированность при недержании мочи и кала.
- 3 подгузника в течение дня и 1 подгузник на ночь с последующей бережной гигиенической процедурой



Уход за кожей



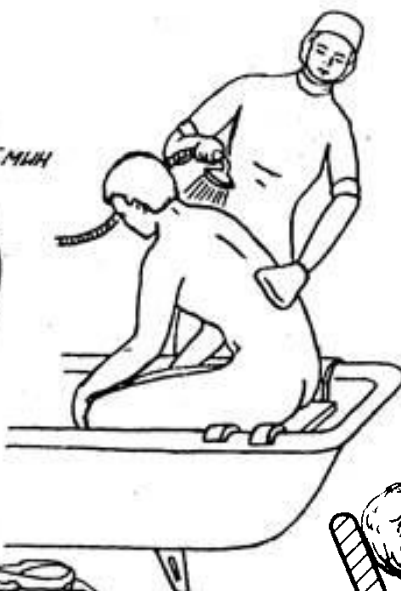
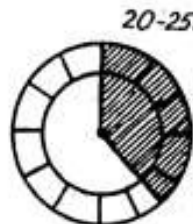
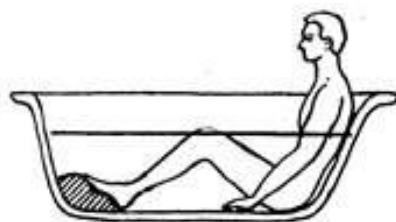
- ▶ **Очистка;**
- ▶ **Стимуляция кровообращения;**
- ▶ **Гигиенический и эмоциональный комфорт.**

- Умывать лицо не реже 2-х раз в день – утром и вечером.
- Мытье головы, душ или ванна (если возможно) – 1 раз в неделю.
- Влажное обтирание кожи – ежедневно не реже 3-х раз в день.
- Мытье рук – перед каждым приемом пищи.
- Мытье ног – не реже 1 раза в 3 дня.

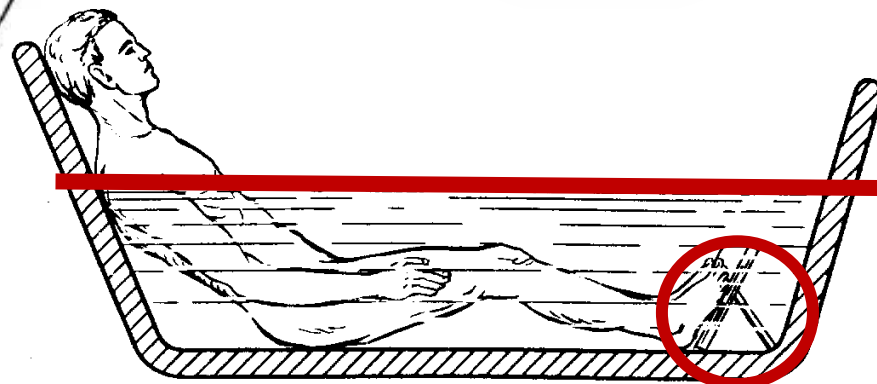
Гигиеническая ванна



1. Закрывать форточки (температура воздуха в ванной комнате должна быть не менее 25°C), положить на пол у ванны резиновый коврик (при отсутствии деревянного настила).
2. Дезинфицировать ванну.
3. Разложить необходимое оснащение.



4. Наполнить ванну (сначала холодной, а затем горячей водой на $2/3$ объёма: такая последовательность заполнения ванны позволяет уменьшить образование паров в ванной комнате)
5. Температура воды должна быть в пределах $34-36^{\circ}\text{C}$.
6. Раздеть пациента и поместить его в ванну.





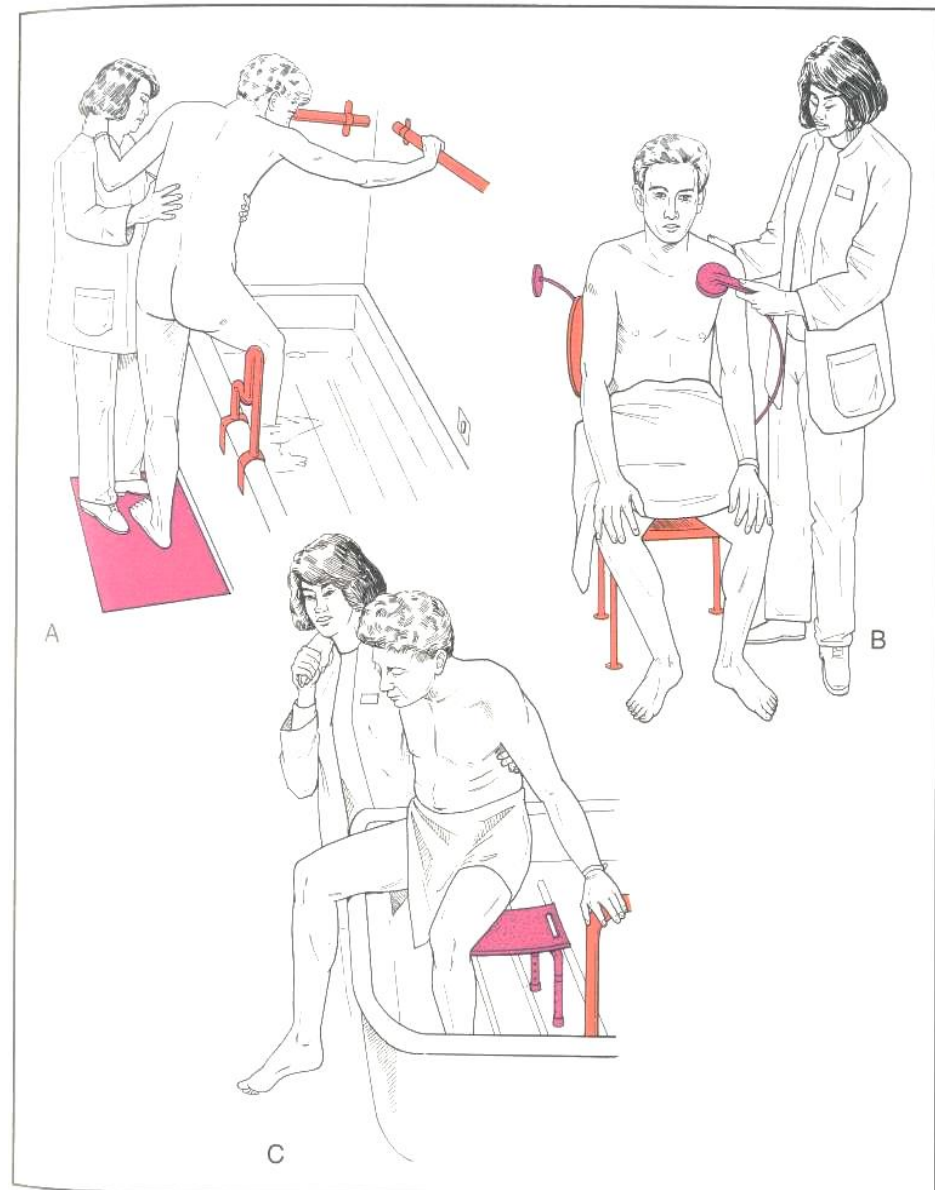
1. Придать больному положение в ванне полусидя так, чтобы вода доходила до верхней трети его груди;
2. В ножной конец ванны поставить деревянную подставку, чтобы больной мог упереться в неё ногами, не скатился и не соскользнул.
3. Если больной не может мыться самостоятельно, вымыть его в последовательности: **голова – туловище – руки – паховая область – промежность – ноги.**
4. Помочь пациенту выйти из ванны, вытереть его в том же порядке.
5. Одеть пациента в чистую одежду.
6. Обработать ванну дезинфицирующим средством, дезинфицировать мочалку.



Гигиенический душ



1. Помочь пациенту раздеться и усадить его на табурет (скамеечку) в душевой кабинке (ванне), поддерживая под локти.
2. Если больной не может мыться самостоятельно, вымыть его, используя индивидуальные мыло и мочалку, в такой последовательности: **голова – туловище – руки – паховая область – промежность – ноги.**
3. Помочь пациенту выйти из душевой кабинки (ванны), вытереть его в том же порядке.
4. Одеть пациента в чистую одежду.
5. Обработать душевую кабину (ванну) дезинфицирующим средством, дезинфицировать мочалку.



Уход за естественными складками



- ▶ **Мацерация кожи** - размягчение и разрыхление тканей вследствие действия на них жидкости.
- ▶ **Опрелость** – воспаление кожи в складках, возникающее при трении влажных поверхностей.
- ▶ Развиваются под молочными железами, в межягодичной складке, подмышечных впадинах, между пальцами ног при повышенной потливости, в паховых складках.
- ▶ Их появлению способствует избыточное выделение кожного сала, недержание мочи.
- ▶ При опрелости кожа краснеет, её роговой слой как бы размокает и отторгается, появляются мокнущие участки с неровными контурами, образуются трещины.



Опрелости



Здоровая кожа

Легкая опрелость

**1 стадия -
эритема**



Умеренная опрелость



Средняя опрелость

**2 стадия -
мокнутие**



Тяжелая опрелость



Тяжелая опрелость

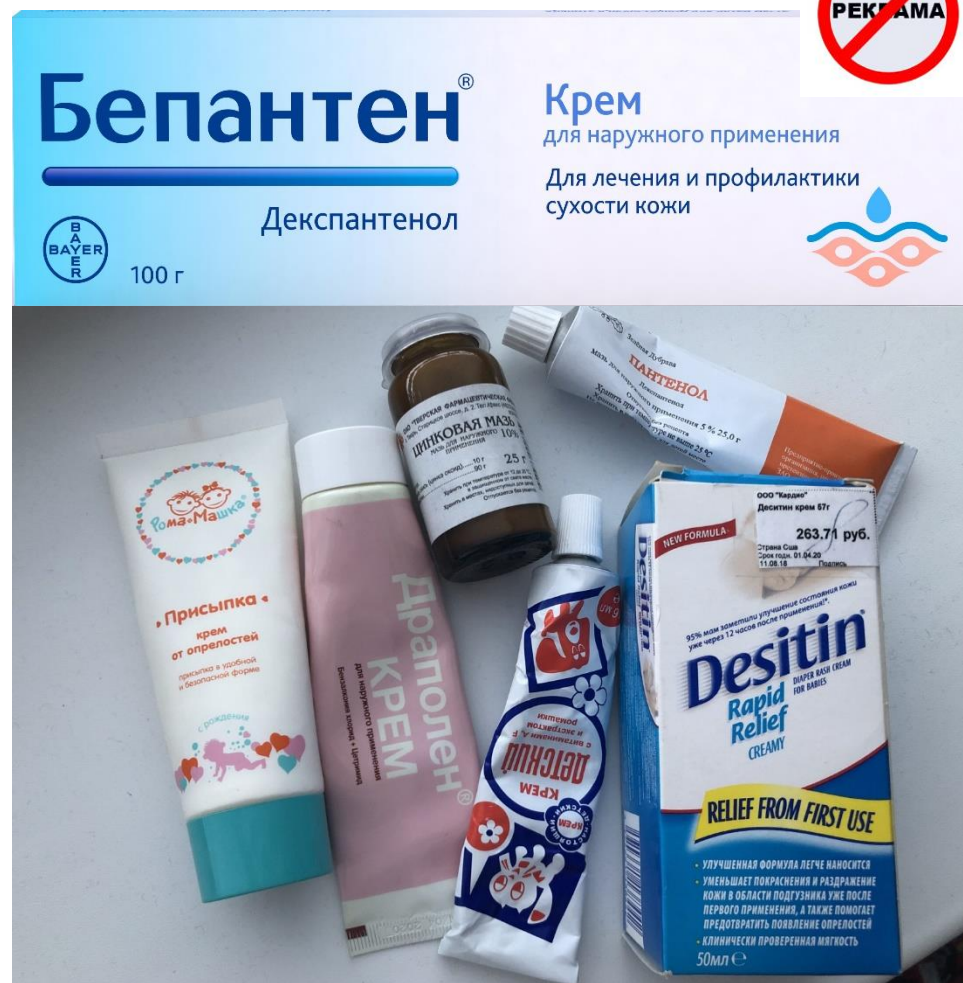
**3 стадия -
эрозия**



Профилактика опрелостей



- ▶ Поддержание оптимальной температуры в палате – не выше +22 0 С.
- ▶ Проветривание.
- ▶ Использование чистого, сухого х/б белья.
- ▶ Регулярный туалет кожи тёплой водой
- ▶ Подмывание после каждого мочеиспускания и дефекации.
- ▶ Воздушные ванны для складок кожи, прокладки между пальцами ног или рук.
- ▶ При недержании мочи и /или кала применять подгузники и регулярно их менять.

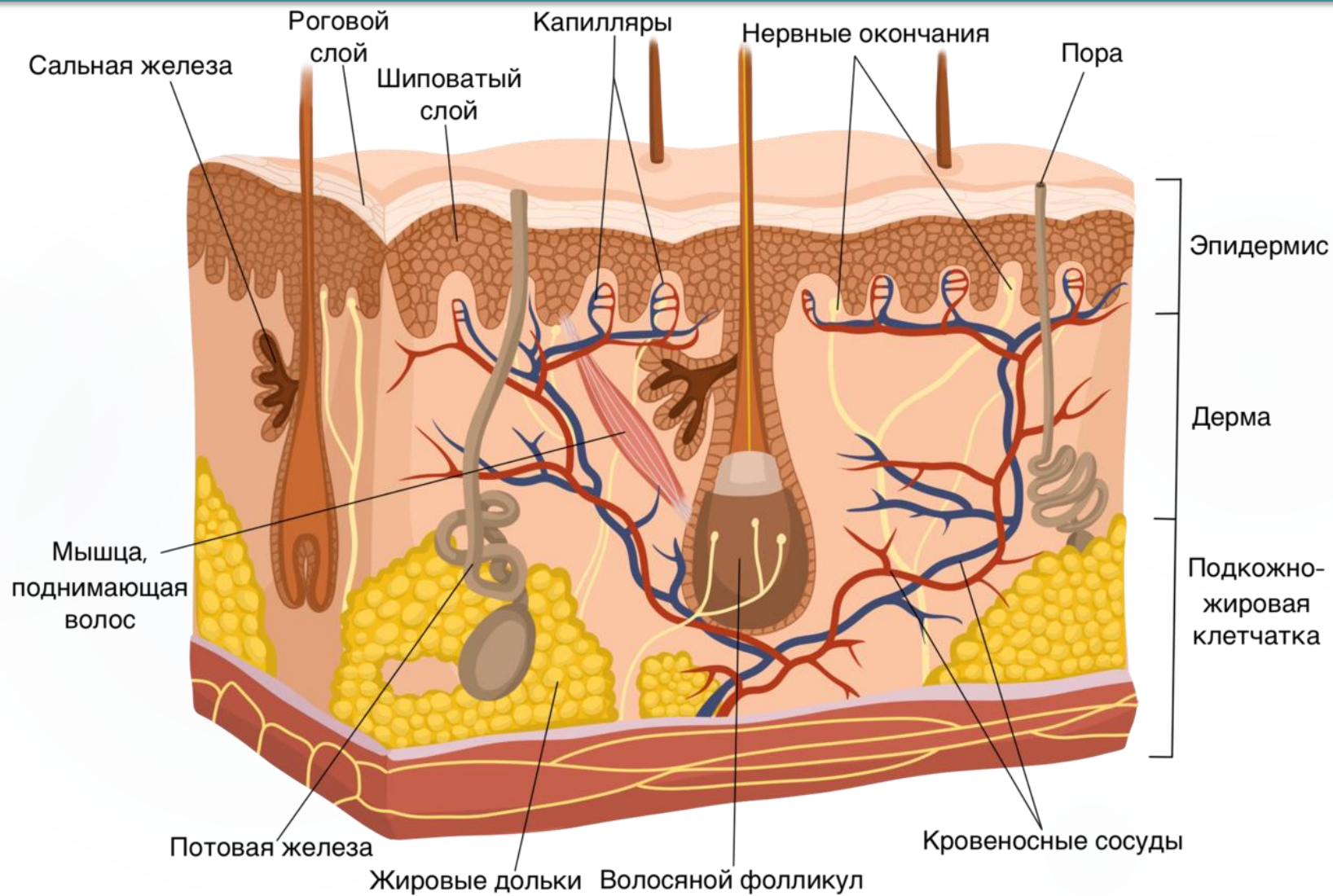


ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Профилактика пролежней

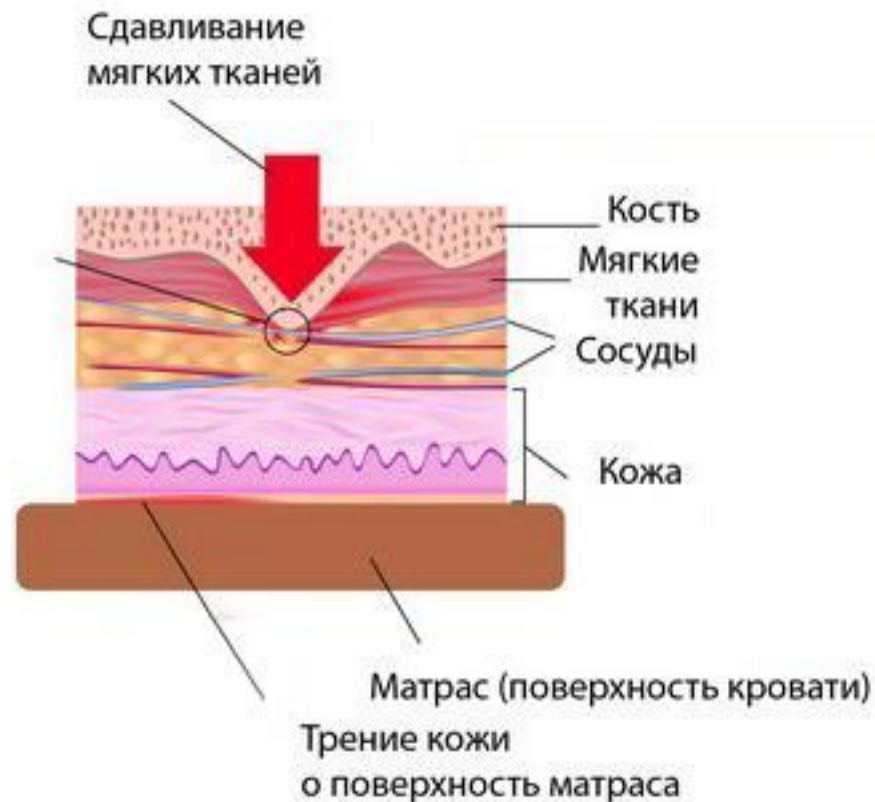
Строение кожи



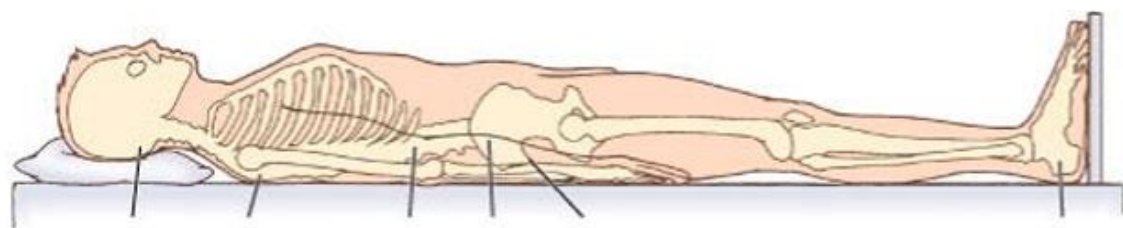
Пролежень



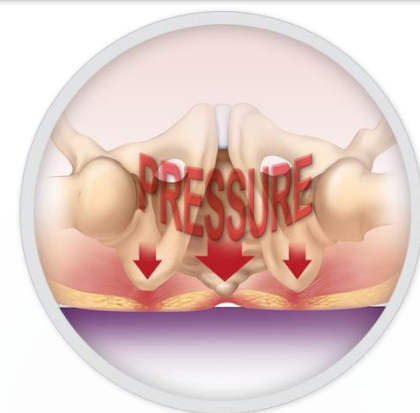
- ▶ лат.- **decubare** – лежать
- ▶ дистрофические, язвенно-некротические изменения мягких тканей, в результате их длительного сдавливания.
- ▶ Пролежень возникает в результате локальной недостаточности кровоснабжения (ишемии) и обусловленной этим смертью клеток (некрозом).
- ▶ Непрерывное давление 70 мм рт.ст. в течение 2 часов вызывает необратимые изменения в тканях.



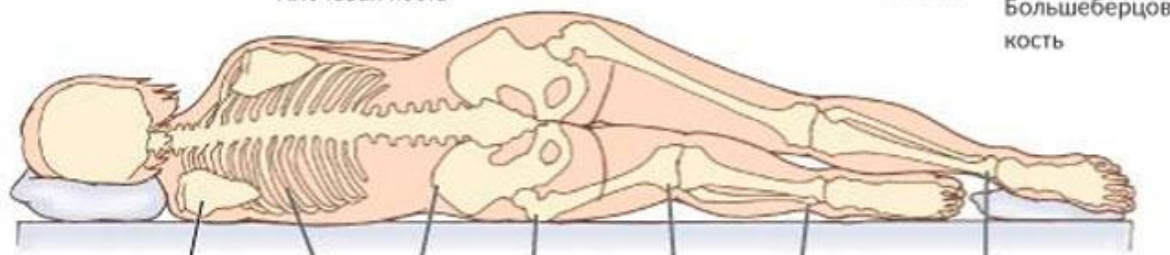
Места возникновения пролежней



Затылок Лопатка Позвоночник Крестец и копчик



Лобная кость Нижняя челюсть Грудина Костные выступы таза Коленная чашечка Большеберцовая кость
Плечевая кость



Лопатка Рёбра Гребень подвздошной кости Большой вертел бедренной кости Наружная лодыжка Внутренняя лодыжка Наружная поверхность коленного сустава



Лопатки

Ягодицы

Подушечки пальцев

Пятки

Стадии пролежней

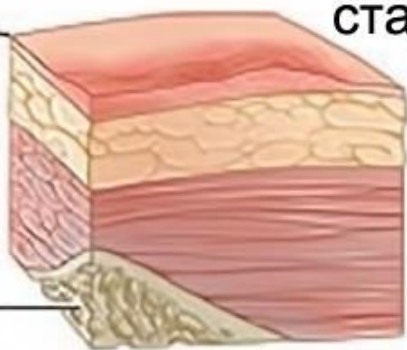


кожа

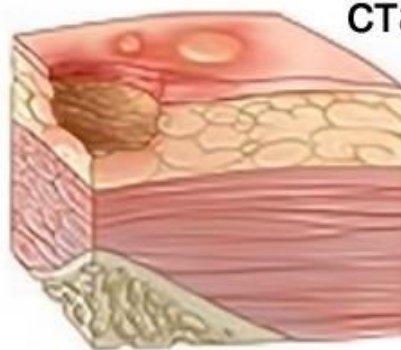
мягкие
ткани

кость

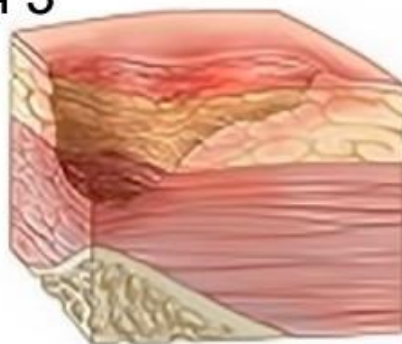
стадия 1



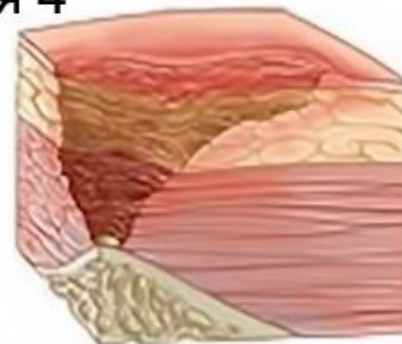
стадия 2



стадия 3



стадия 4



Клиника развития пролежней



- ▶ **1 стадия:** устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекращения давления; кожные покровы не нарушены.
- ▶ **2 стадия:** стойкая гиперемия кожи; отслойка эпидермиса; поверхностное (неглубокое) нарушение целостности кожных покровов (некроз) с распространением на подкожную клетчатку.
- ▶ **3 стадия:** разрушение (некроз) кожных покровов вплоть до мышечного слоя с проникновением в мышцу; могут быть жидкие выделения из раны.
- ▶ **4 стадия:** поражение (некроз) всех мягких тканей; наличие полости, в которой видны сухожилия и/или костные образования.

Внутренние факторы риска



↙ **обратимые**

истощение
ограничение подвижности
анемия
недостаточное употребление
протеина, аскорбиновой кислоты
обезвоживание
гипотензия
недержание мочи и/или кала
неврологические расстройства (сенсорные, двигательные)
нарушение периферического кровообращения
истонченная кожа
беспокойство
спутанное сознание
кома

↘ **необратимые**

старческий возраст



Внешние факторы риска

обратимые

плохой гигиенический уход
складки на постельном и\или
нательном белье
поручни кровати
средства фиксации пациента
травмы позвоночника, костей таза,
органов брюшной полости
повреждения спинного мозга
неправильная техника перемещения пациента в кровати
применение цитостатических лекарственных средств

необратимые

обширное
хирургическое
вмешательство
продолжительностью
более двух часов

Шкала Ватерлоо (Waterlow) – 1985



Телосложение: масса относительно роста		Тип кожи	
Среднее	0	Здоровая	0
Выше среднего	1	Папиросная бумага	1
Ожирение	2	Сухая	1
Ниже среднего	3	Отечная	1
Пол		Липкая (повышенная температура)	1
Мужской	1	Изменение цвета	2
Женский	2	Трещины, пятна	3
Возраст		Особые факторы риска	
14-49	1	Нарушение питания кожи (кахексия)	8
50-64	2	Сердечная недостаточность	5
65-74	3	Болезни периферических сосудов	5
75-81	4	Анемия	2
Более 81	5	Курение	1

Шкала Ватерлоо (продолжение)



Недержание		Аппетит	
Полный контроль, через катетер	0	Средний	0
Периодическое	1	Плохой	1
Через катетер, недержание кала	2	Питательный зонд, только жидкости	2
Кала и мочи	3	Не через рот, анорексия	3
Подвижность		Неврологические расстройства	
Полная	0	Диабет, инсульт, множественный склероз	4,5,6
Беспокойный, суетливый	1	Обширное оперативное вмешательство	
Адаптивный	2	Более 2 часов на столе	5
Ограниченная подвижность	3	Ортопедическое (ниже пояса, позвоночник)	5
Иннертный	4	Лекарственная терапия	
Прикован к креслу	5	Цитостатические препараты	4
		Высокие дозы стероидов	4
		Противовоспалительные	4

Оценка по шкале Ватерлоо



- ▶ нет риска 1 – 9 баллов;
- ▶ есть риск 10 баллов;
- ▶ высокая степень риска 15 баллов;
- ▶ очень высокая степень риска 20 баллов.



Оказание помощи. Вопросы профилактики



Приложение к приказу
Минздрава России
от 17.04.02 № 123

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Протокол ведения больных.
Пролежни (I.89)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
56819—
2015

НАДЛЕЖАЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА
ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ

Общие подходы к профилактике пролежней:

1. своевременная диагностика риска развития пролежней
2. своевременное начало выполнения всего комплекса профилактических мероприятий
3. адекватная техника выполнения простых медицинских услуг, в т. ч. по уходу.

Направления профилактических мероприятий



- ▶ уменьшение давления на костные ткани;
- ▶ предупреждение трения и сдвига тканей во время перемещения пациента или при его неправильном размещении («сползание» с подушек, положение «сидя» в кровати или на кресле);
- ▶ наблюдение за кожей над костными выступами;
- ▶ поддержание чистоты кожи и ее умеренной влажности (не слишком сухой и не слишком влажной);
- ▶ обеспечение пациента адекватным питанием и питьем;
- ▶ обучение пациента приемам самопомощи для перемещения;
- ▶ обучение близких.

Размещение в кровати



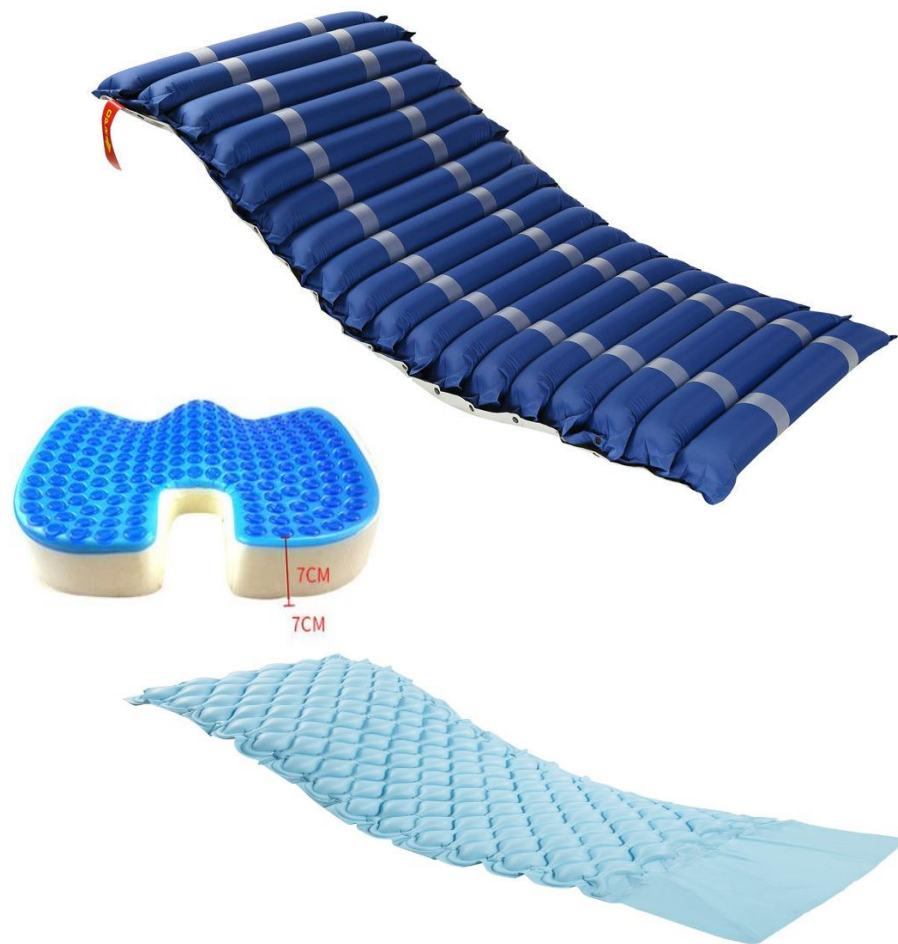
- ▶ Кровать – функциональная;
 - ▶ Поручни с обеих сторон;
 - ▶ Устройство для приподнимания изголовья кровати;
 - ▶ Специальный матрац: не панцирная сетка;
 - ▶ Высота кровати должна быть на уровне середины бедер ухаживающего за пациентом.
-
- ▶ Пациент, перемещаемый или перемещающийся в кресло, должен находиться на кровати с изменяющейся высотой, позволяющей ему самостоятельно, с помощью других подручных средств перемещаться из кровати.



Противопролежневый матрас



- ▶ Выбор зависит от степени риска развития пролежней и массы тела пациента.
- ▶ При низкой степени риска может быть достаточно поролонового матраса толщиной 10 см.
- ▶ При более высокой степени риска, а также при имеющихся пролежнях разных стадий нужны другие матрасы.
- ▶ При размещении пациента в кресле (кресле-каталке) под ягодицы и за спину помещаются поролоновые подушки, толщиной 10 см.
- ▶ Под стопы помещаются поролоновые прокладки, толщиной не менее 3 см
- ▶ Постельное белье – хлопчатобумажное.
- ▶ Одежда – легкое.



Под уязвимые участки необходимо подкладывать валики и подушки из поролона.



Изменение положения тела

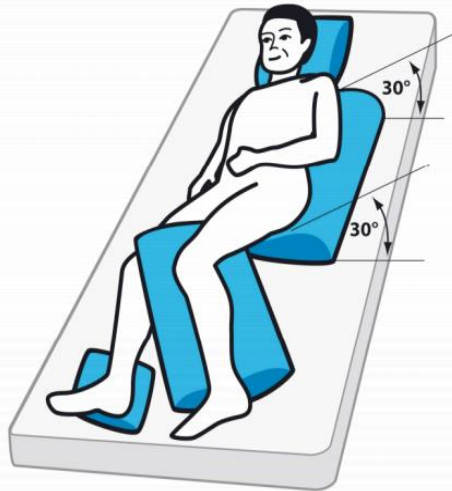


осуществлять каждые 2 часа, в т. ч. в ночное время, по графику:

- ▶ низкое положение Фаулера,
- ▶ положение «на боку»,
- ▶ положение Симса,
- ▶ положение «на животе» (по согласованию с врачом).
- ▶ Положение Фаулера должно совпадать со временем приема пищи.

Сестринские вмешательства	Кратность
1. Проведение текущей оценки риска развития пролежней не менее 1 раза в день (утром) по шкале Ватерлоу	Ежедневно 1 раз
2. Изменение положения пациента каждые 2 часа: 8-10 ч. – положение Фаулера;	Ежедневно 12 раз
10-12 ч. – положение «на левом боку»;	
12-14 ч. – положение «на правом боку»;	
14-16 ч. – положение Фаулера;	
16-18 ч. – положение Симса;	
18-20 ч. – положение Фаулера;	
20-22 ч. – положение «на правом боку»;	
22-24 ч. – положение «на левом боку»;	
0-2 ч. – положение Симса;	
2-4 ч. – положение «на правом боку»;	
4-6 ч. – положение «на левом боку»;	
6-8 ч. – положение Симса	

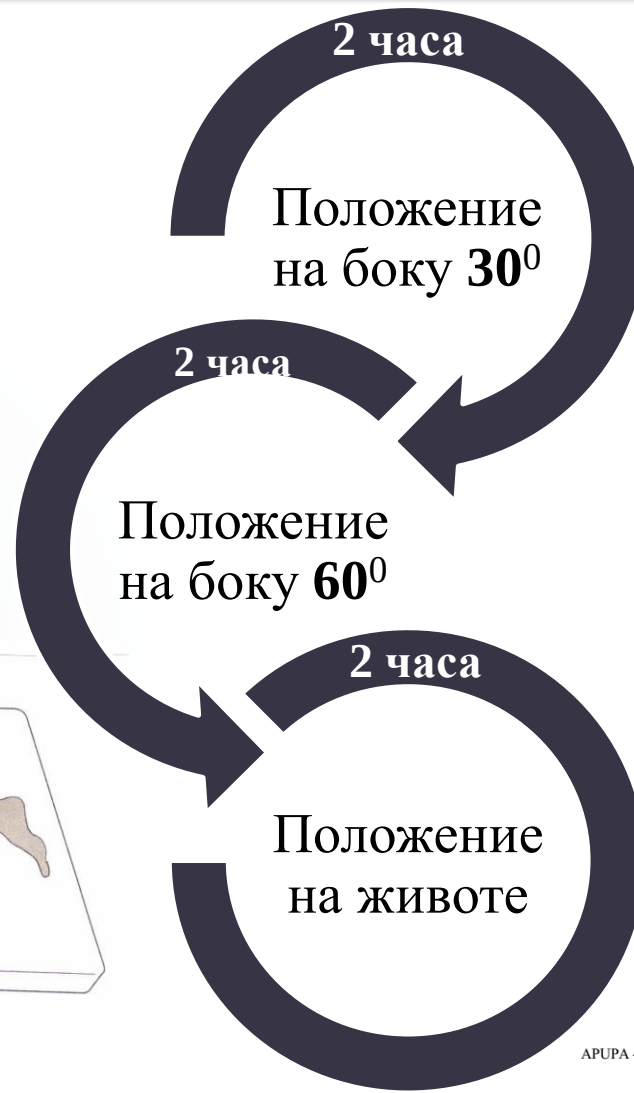
Обеспечение подвижности



на боку в 30°



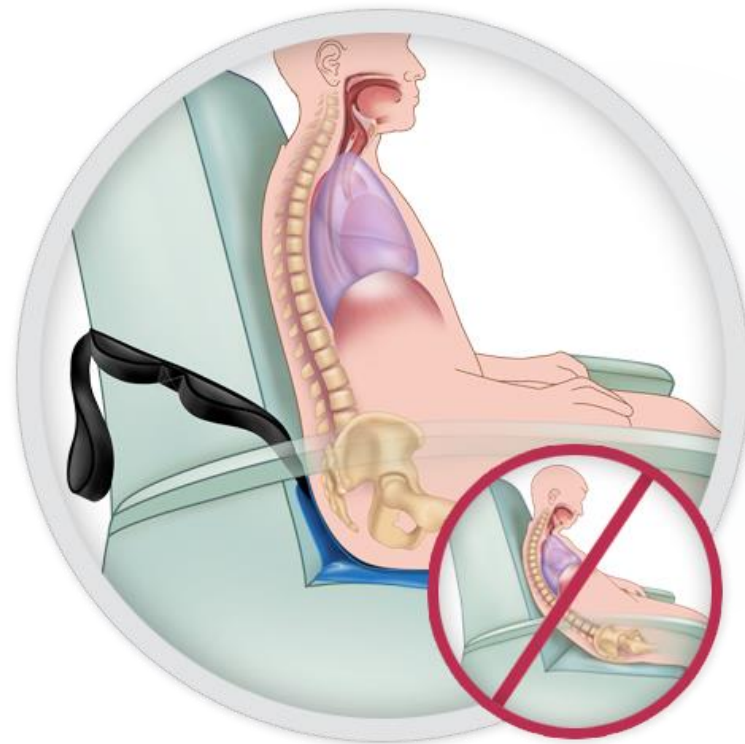
положение Симса



на боку в 60°

Положение пациентов на боку в 90° **НЕДОПУСТИМО**

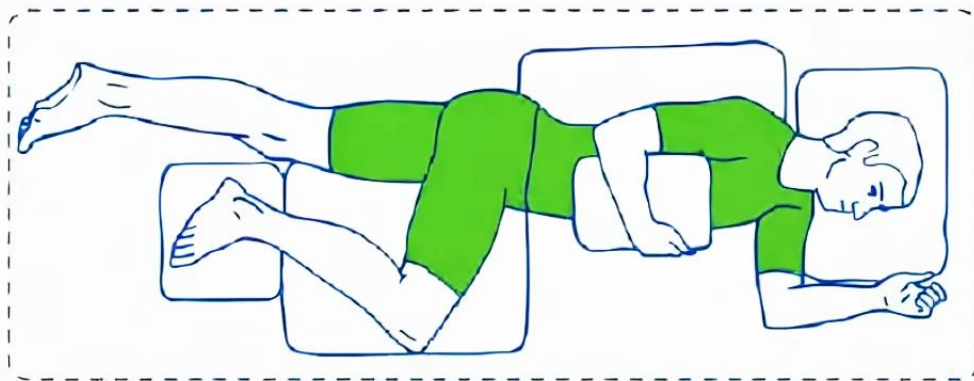
Положение Фаулера



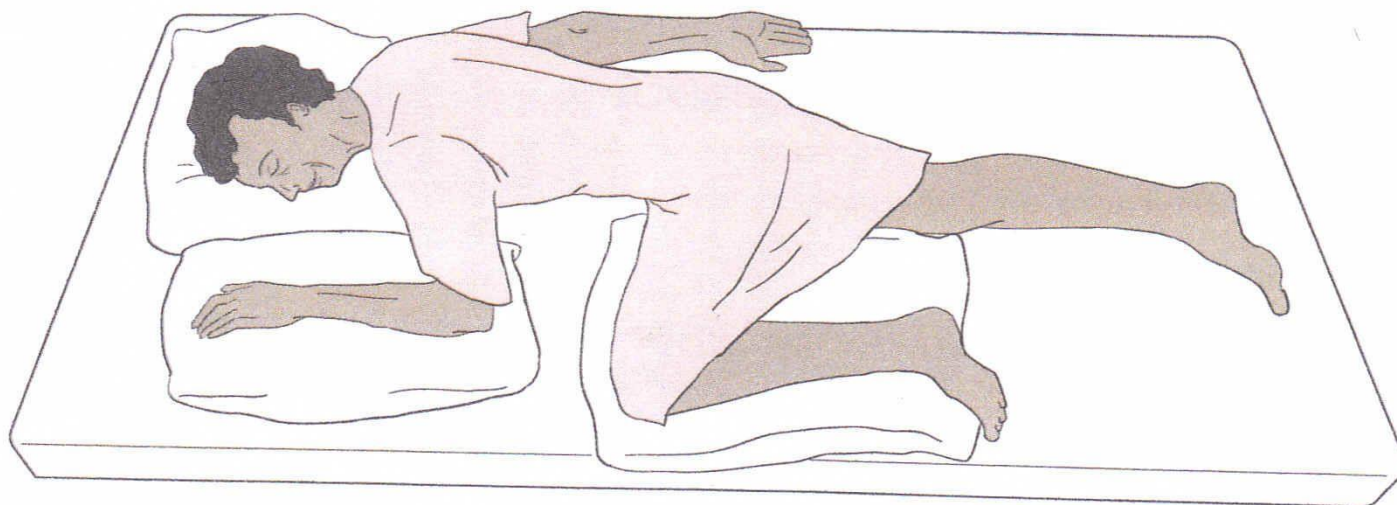
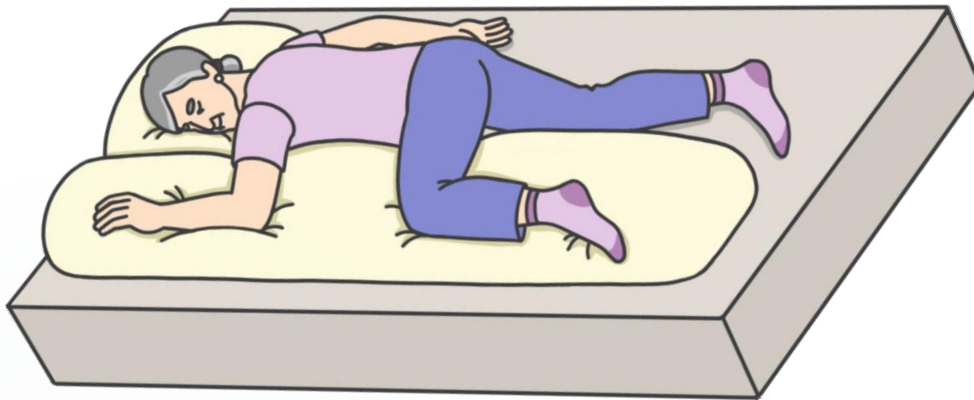
Повороты



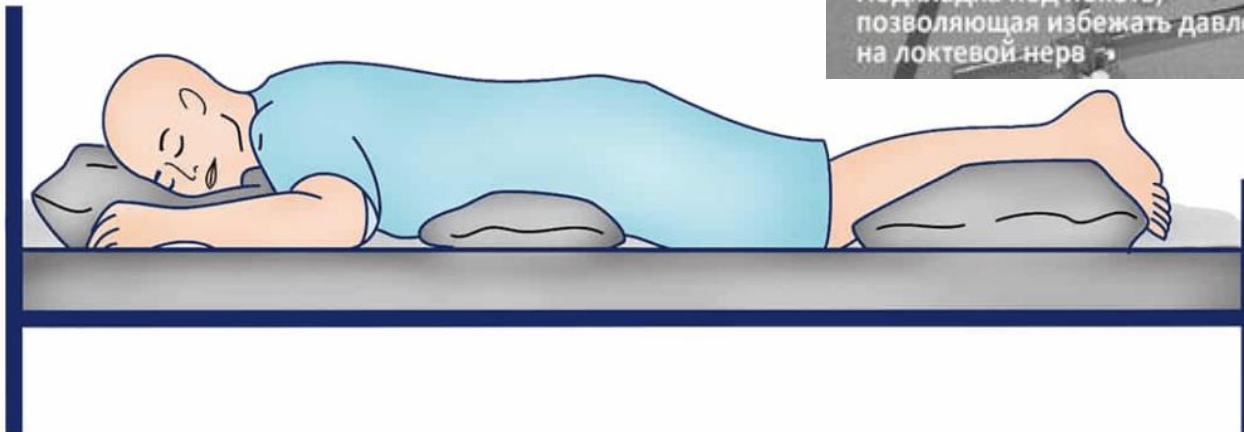
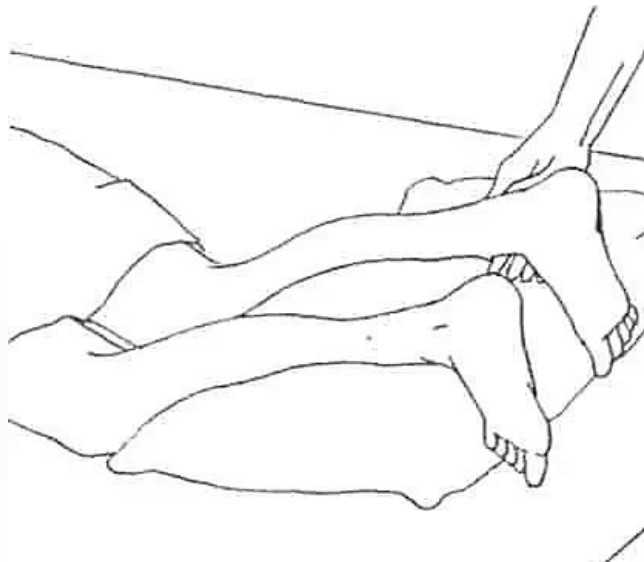
Положение на боку (левом / правом)



Положение Симса



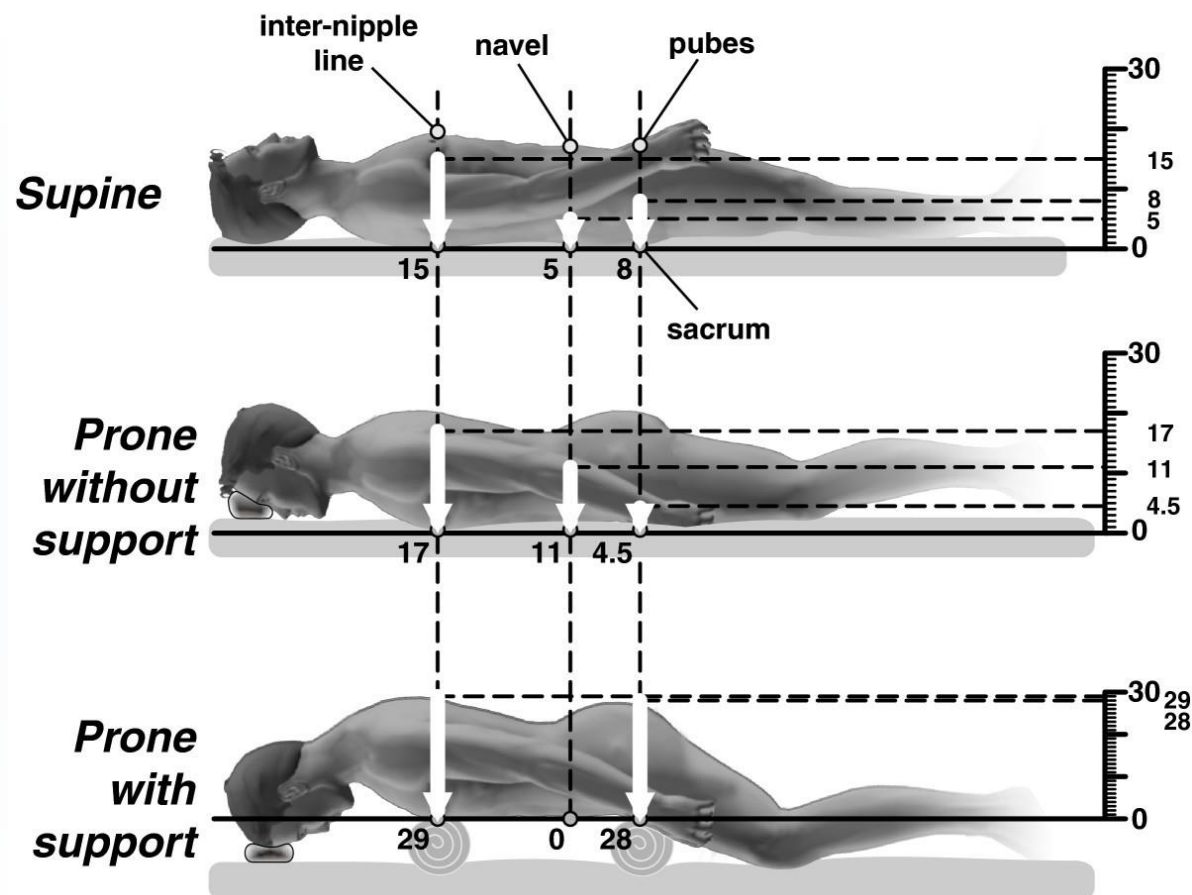
Положение на животе Pron-position



Изменение давления на кожу и мягкие ткани в зависимости от положения пациента



Contact Pressure (cmH₂O)



Тест «пальцем»



- ▶ Рекомендуется в качестве критерия для планирования временных интервалов изменения положения тела пациента;
- ▶ Нажать пальцем на кожу в подкостной области;
- ▶ Непроходящее после нажатия покраснение указывает на нарушение микроциркуляции крови.



Рекомендации отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни».

Продолжение



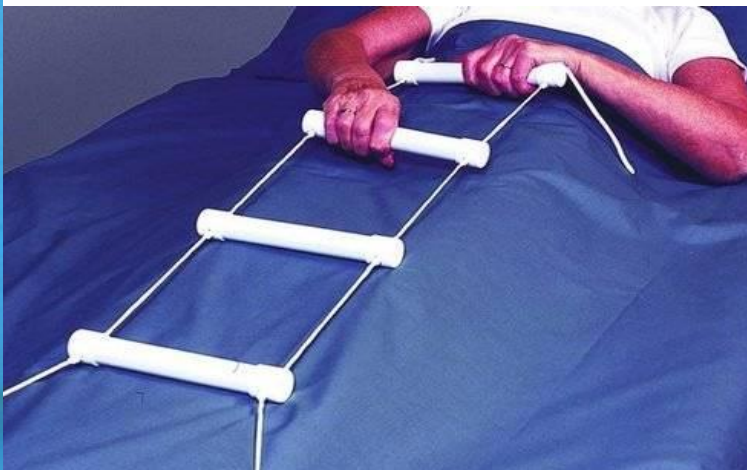
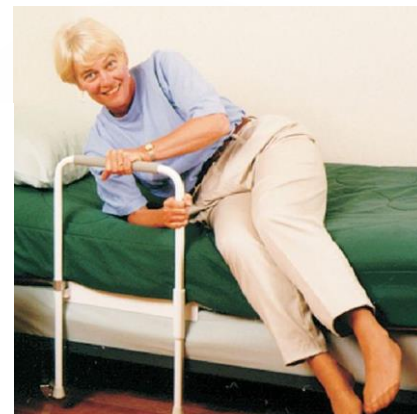
- ▶ Перемещение пациента осуществлять бережно, исключая трение и сдвиг тканей, приподнимая его над постелью, или используя подкладную простыню.
- ▶ Не допускать, чтобы в положении «на боку» пациент лежал непосредственно на большом вертеле бедра.
- ▶ Не подвергать участки риска трению. Массаж всего тела, в т. ч. около участков риска (в радиусе не менее 5 см от костного выступа) проводить после обильного нанесения питательного (увлажняющего) крема на кожу.
- ▶ Мытье кожи проводить **без трения и кускового мыла**, использовать жидкое мыло. Тщательно высушивать кожу после мытья промокающими движениями.
- ▶ Использовать непромокаемые пеленки и подгузники, уменьшающие чрезмерную влажность.

Рекомендации отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни».

Продолжение



- ▶ Максимально расширять активность пациента: обучить его самопомощи для уменьшения давления на точки опоры. Поощрять его изменять положение: поворачиваться, используя поручни кровати, подтягиваться.



Научить родственников и других лиц, осуществляющих уход, уменьшать риск повреждения тканей под действием давления



- ▶ регулярно изменять положение тела;
- ▶ использовать приспособления, уменьшающие давление (подушки, поролон, прокладки);
- ▶ соблюдать правила приподнимания и перемещения: исключать трение и сдвиг тканей;
- ▶ осматривать всю кожу не реже 1 раза в день, а участки риска — при каждом перемещении;
- ▶ осуществлять правильное питание и адекватный прием жидкости;
- ▶ правильно осуществлять гигиенические процедуры: исключать трение

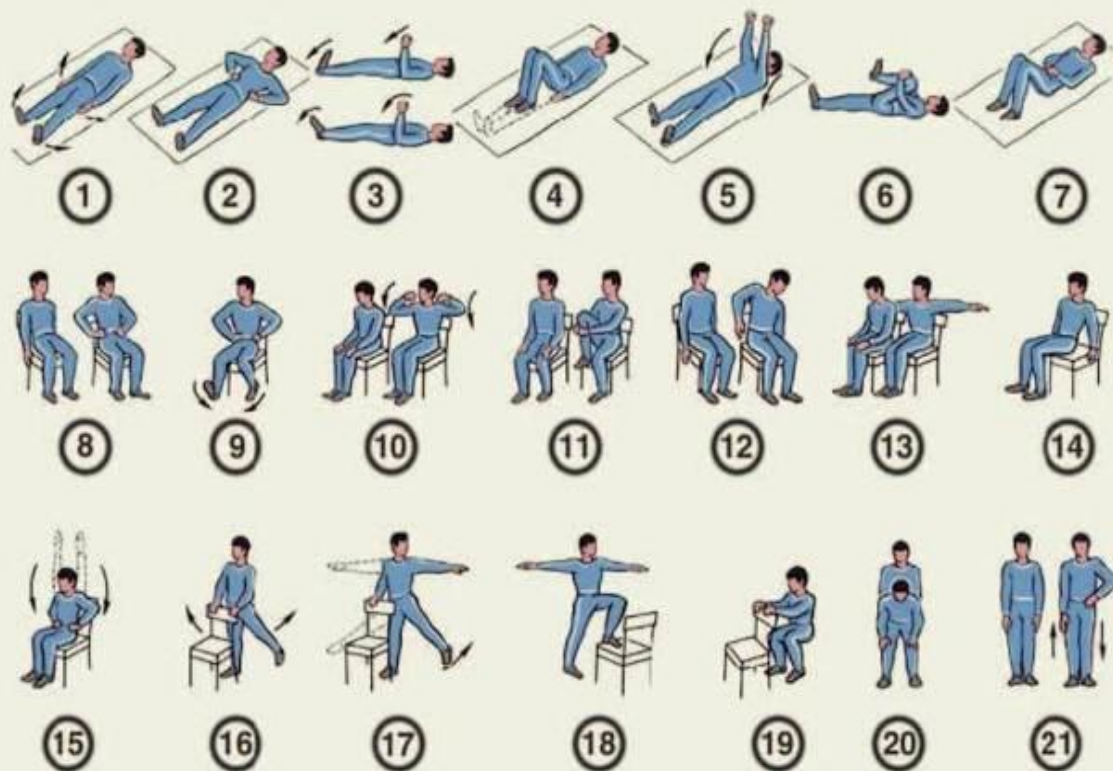


Рекомендации отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни».

Продолжение



- ▶ Не допускать чрезмерного увлажнения или сухости кожи: при чрезмерном увлажнении - подсушивать, используя присыпки без талька, при сухости - увлажнять кремом;
- ▶ Постоянно поддерживать комфортное состояние постели: стряхивать крошки, расправлять складки;
- ▶ Обучить пациента дыхательным упражнениям и поощрять его выполнять их каждые 2 часа.



Общая схема лечения пролежней

Первичная оценка общей ситуации:

- место образования пролежня, степень тяжести, общее состояние раны;
- оценка статуса пациента.

Лечение

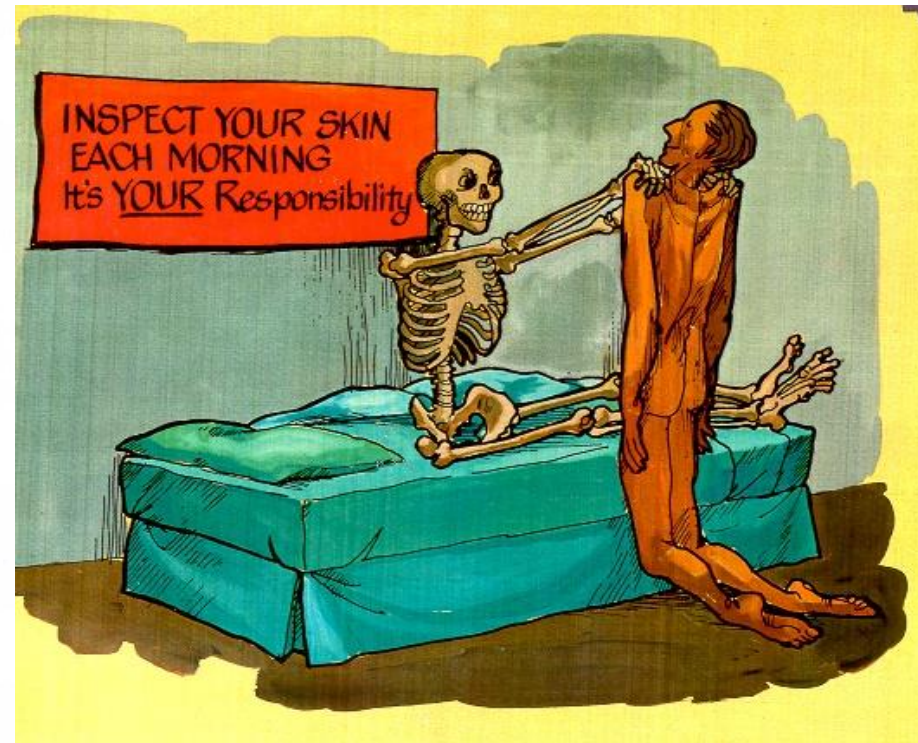
Этиологическая терапия: полное устранение давления на пролежень до заживления.

Местная терапия: адекватная обработка и лечение раны.

Зажил ли пролежень?

ДА: контроль и продолжение терапии согласно плану лечения.

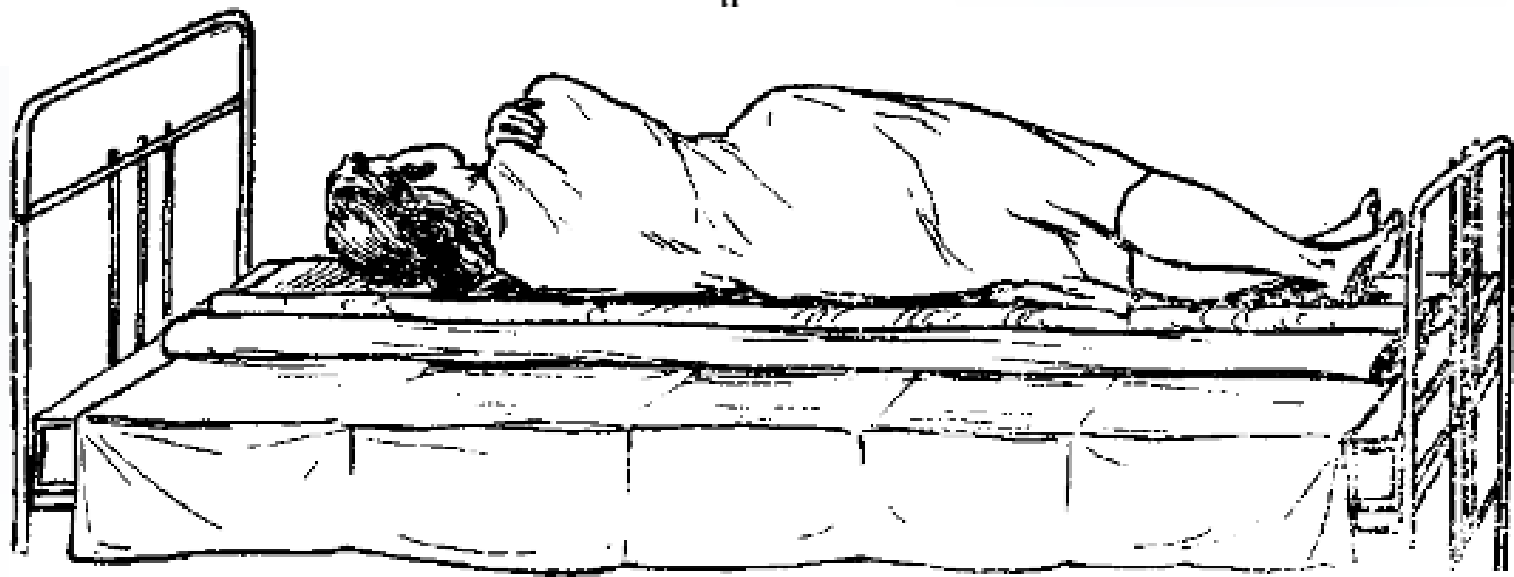
НЕТ: тщательная проверка качества выполняемых мероприятий, особенно снятие нагрузки.



Смена нательного белья



Смена постельного белья



Дезинфекция постельных принадлежностей



- ▶ Смена белья не реже 1 раза в 7 дней и по мере загрязнения!
- ▶ У родильниц смена белья каждые 3 дня и по мере загрязнения
- ▶ Обязательна после каждого убытия пациента (выпуска, перевод, смерть), а также по эпид. показаниям.
- ▶ Дезинфекционной обработке также подлежат кровать и тумбочка пациента (все «личное пространство»).
- ▶ Проводится в дезинфекционной камере (при применении гигиенических намотрасников допускается сан. обработка матрасов в отделении).
- ▶ «В случае использования для покрытия матрасов чехлов из материала, допускающего влажную дезинфекцию, камерная обработка не требуется».
- ▶ Тапочки больных перед выпиской подвергают камерной дезинфекции или обработке разрешенными для этих целей дезинфицирующими средствами.

